

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE
IES

KAREN CHRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

**A SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES NO BRASIL: Desigualdades entre a educação
básica e o ensino superior**

Porto Alegre

2026

KAREN CHRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

**A SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES NO BRASIL: Desigualdades entre a educação
básica e o ensino superior**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
Educação em Ciências – Associação de IES do
Instituto de Ciências Básicas da Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul como
requisito parcial para a obtenção do título de doutora
em Educação em Ciências.

Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Staniscuaski
Coorientadora: Profa. Dra. Letícia de Oliveira

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Rodrigues dos Santos, Karen Christina
A SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES NO BRASIL:
Desigualdades entre a educação básica e o ensino
superior / Karen Christina Rodrigues dos Santos. --
2026.
103 f.
Orientadora: Fernanda Staniscuaski.

Coorientadora: Leticia de Oliveira.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde,
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências -
Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Saúde mental. 2. Professores. 3. Ensino Básico.
4. Depressão. 5. Raça. I. Staniscuaski, Fernanda,
orient. II. de Oliveira, Leticia, coorient. III.
Título.

KAREN CHRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

A SAÚDE MENTAL DOS DOCENTES NO BRASIL: Desigualdades entre a educação básica e o ensino superior

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito para a obtenção do Título de Doutor em Educação em Ciências.

Profa. Dra. Fernanda Staniscuaski

Orientadora

Profa. Dra. Letícia de Oliveira

Coorientadora

Aprovado em: 26/02/2026

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Maria Cecília Moço - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Mirtes Garcia Pereira - Departamento de Fisiologia e Farmacologia -
Universidade Federal Fluminense

Profa. Dra. Ana Cristina Viana Campos - Saúde Coletiva - Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará

Dedico esta tese à minha família, pelo amor, apoio incondicional e compreensão em todos os momentos, e a todos que acreditaram em mim quando eu mesma duvidei, caminhando ao meu lado e oferecendo apoio, paciência e afeto ao longo desta trajetória.

AGRADECIMENTOS

Esta tese é fruto não apenas de um esforço pessoal, mas também do apoio de diversas pessoas que me incentivaram, direta ou indiretamente. Por esse motivo, registro aqui os meus mais sinceros agradecimentos.

A Deus, sempre presente. Aos meus pais, Airton e Elza, pelo amor, pelo apoio logístico, sempre entusiasmados com meus passos no mundo acadêmico; ao meu irmão Andherson, sempre amoroso, pelo apoio durante todo o período do curso.

Ao meu esposo Marcos, meu amor, companheiro de vida e aventuras, pelo incentivo, paciência e apoio constantes. Às minhas filhas, Christieli e Thamiris, pelo carinho, pelo cuidado uma com a outra, pelo amor e pela compreensão, e por me permitirem ser exemplo de que o estudo, a perseverança e os sonhos transformam caminhos.

À minha tia, Aldanir Goularte Rodrigues, pelo apoio constante durante o período do curso, acolhendo-me com amor de mãe.

À minha orientadora, Fernanda Stanisçuaski, por sua dedicação, amorosidade, apoio e paciência, pelas orientações e sugestões sempre pertinentes, e pelo respeito que sempre demonstrou ao nosso trabalho. Foi muito bom poder trabalhar com alguém que tanto admiro.

À minha coorientadora, Leticia de Oliveira, pelas valiosas contribuições, pela sensibilidade, disponibilidade e generosidade com que compartilhou seus conhecimentos, tornando este percurso mais rico e significativo.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, e a seus professores e professoras, pela oportunidade de participação em um doutorado e pelas valiosas contribuições à minha formação acadêmica.

Aos meus colegas do grupo de pesquisa: Rachel Silva Machado, Lana Rony Magalhães Martins, Arthur V. Machado, Sarah Rocha Alves, Marta Nudelman e Mirtes Pereira, pelas trocas generosas, pelo apoio constante, pelas escutas atentas e pela ajuda cuidadosa no processo de escrita, que tornaram esta caminhada mais leve e significativa.

À minha amiga Natalia pelo cuidado na formatação deste trabalho e a todos que de alguma forma me apoiaram nessa caminhada.

RESUMO

Esta tese teve como objetivo avaliar a saúde mental de docentes do ensino básico, em uma perspectiva comparativa com a do ensino superior no Brasil, considerando a prevalência de sintomas depressivos e de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), bem como níveis de otimismo e solidão. O estudo adotou uma abordagem quantitativa, utilizando um questionário online que foi respondido por 1711 docentes do ensino básico e superior de todas as regiões do país, com o objetivo de coletar informações sociodemográficas e avaliar sintomas de depressão e TEPT, bem como a influência de fatores como solidão e otimismo, utilizando escalas psicométricas validadas para a população brasileira. Os resultados demonstraram que, embora 29,6% dos docentes do ensino superior tenham ultrapassado o ponto de corte da escala Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9), o que indicou uma maior probabilidade de diagnóstico de depressão, o dado mais preocupante referiu-se aos docentes da educação básica, entre os quais 49,1% apresentaram possível diagnóstico de depressão, configurando um cenário particularmente alarmante para o ensino básico. Nesse mesmo segmento, as mulheres apresentaram escores médios mais altos e maior proporção acima do ponto de corte, em comparação aos homens. O histórico prévio de transtorno psiquiátrico foi o fator de risco mais relevante para um provável diagnóstico de depressão. Entre docentes negros da educação básica, observou-se maior porcentagem de docentes acima do ponto de corte, embora a diferença entre a pontuação média na escala não tenha alcançado significância estatística. Da mesma forma, a parentalidade também não apresentou efeito estatisticamente significativo. Em relação ao TEPT, identificaram-se prevalências relevantes de provável diagnóstico entre docentes, com 21,6% na educação básica e 9,3% no ensino superior. Os resultados também evidenciaram que os docentes da educação básica estavam mais suscetíveis ao sentimento de solidão quando comparados aos docentes do ensino superior. No que se refere ao otimismo, constatou-se que docentes do ensino superior apresentaram níveis significativamente mais elevados do que docentes da educação básica. Os resultados empíricos refletiram tanto condições laborais adversas como desigualdades estruturais entre ensino básico e ensino superior. Concluiu-se que fortalecer a saúde mental do professorado é condição estratégica para garantir ensino de qualidade e reduzir desigualdades educacionais; isso exige políticas robustas, sustentáveis e sensíveis às múltiplas identidades presentes nas instituições de ensino brasileiras, além de pesquisas futuras que acompanhem a eficácia das intervenções ao longo do tempo.

Palavras-Chave: Saúde mental; Professores; Ensino básico; Depressão; Gênero; Raça

ABSTRACT

This thesis investigated, in an integrated manner, the mental health of basic and higher education teachers in Brazil, with a specific focus on the prevalence of psychological distress symptoms and the influence of different factors on these symptoms. The study adopted a quantitative approach, using an online questionnaire answered by 1,711 basic and higher education teachers from all regions of the country. The objective was to collect sociodemographic information and assess symptoms of Depression and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), as well as the influence of factors such as Loneliness and Optimism, using psychometric scales validated for the Brazilian population. The results showed that, although 29.6% of higher education teachers exceeded the cutoff score of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), which assessed depression, the most concerning finding referred to basic education teachers, among whom 49.1% presented a probable diagnosis of depression, configuring a particularly alarming scenario in basic education. Within this same group, women presented higher mean scores and a greater proportion above the cutoff compared to men. A previous history of psychiatric disorder was identified as the most relevant risk factor for a probable diagnosis of depression. Among Black basic education teachers, a higher percentage exceeded the cutoff score, although the difference in mean scores did not reach statistical significance. Similarly, parenthood did not show a statistically significant effect. Regarding PTSD, relevant prevalences of probable diagnosis were identified among teachers, with rates of 21.6% in basic education and 9.3% in higher education. The results also indicated that basic education teachers were more susceptible to feelings of loneliness when compared to higher education teachers. With respect to optimism, higher education teachers presented significantly higher levels than basic education teachers. The empirical findings reflected both adverse working conditions and structural inequalities between basic and higher education. It was concluded that strengthening teachers' mental health is a strategic condition for ensuring quality education and reducing educational inequalities; this requires robust, sustainable public policies that are sensitive to the multiple identities present in Brazilian educational institutions, as well as future research that monitors the effectiveness of interventions over time.

Keywords: Mental health; Teachers; Basic education; Depression; Gender; Race

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 01 - Escala de depressão (PHQ-9)	37
Figura 02 - Escala de TEPT (PCL-5)	38
Figura 03 - Escala de Solidão (TILS)	38
Figura 04 - Escala de otimismo (LOT-R)	39

TABELAS

Tabela 1 - Características sociodemográficas da amostra (n = 1711)

38

LISTA DE SIGLAS

APA	American Psychiatric Association
BDI	Inventário de Depressão de Beck
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
CEP	Comitê de Ética e Pesquisa
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
DSM-5	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª ed.)
DSM-IV	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (4ª ed.)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LABNeC	Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento
LOT-R	Life Orientation Test – Revised
OMS	Organização Mundial da Saúde
PCL-5	Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5
PHQ-9	Patient Health Questionnaire 9
PTSD	Post-Traumatic Stress Disorder
SEPLAG	Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão
SARS-CoV-2	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
TEPT	Transtorno de Estresse Pós-Traumático
TILS	Three-Item Loneliness Scale
UCLA	University of California, Los Angeles
UERJ	Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFF	Universidade Federal Fluminense
UFOP	Universidade Federal de Ouro Preto
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
Unirio	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
WHO	World Health Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 SAÚDE MENTAL: DESAFIOS NO ENSINO BÁSICO E SUPERIOR	15
2.1 DOCENTES ENSINO BÁSICO	15
2.2 DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR	17
2.3 A PANDEMIA COMO FATOR AGRAVANTE DO ADOECIMENTO MENTAL DOS DOCENTES	18
2.4 DEPRESSÃO	19
2.5 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO	23
2.6 SOLIDÃO	24
2.7 OTIMISMO	25
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS	27
3.1 INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS	27
3.2 AMOSTRA	29
3.3 ANÁLISE DOS DADOS	29
4 ARTIGO DOCÊNCIA E SAÚDE MENTAL: UM RETRATO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL	31
5 ARTIGO UNDERSTANDING DEPRESSION IN BASIC EDUCATION TEACHERS: EVIDENCE FROM BRAZIL	51
6 DISCUSSÃO	64
7 CONCLUSÕES	69
REFERÊNCIAS	64
ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PESQUISADO (FORMATO ONLINE)	86
ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS	93
ANEXO C - QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE	99

1 INTRODUÇÃO

A saúde mental dos docentes tem sido historicamente impactada pelo caráter intenso e complexo do trabalho, situação que se agrava especialmente a partir da década de 1990 com a incorporação de novas tecnologias, a precarização das condições laborais e a ampliação das jornadas (Leão, 2014). A profissão docente é uma função antiga que desde o princípio é acompanhada de problemas decorrentes do ofício, onde a prevalência de docentes em risco de desenvolver transtornos mentais mostra-se significativamente elevada quando comparada à população geral, influenciada por fatores como condições de trabalho desfavoráveis, carência de recursos, inclusive digitais, e episódios de violência no ambiente escolar (Gasparini; Barreto; Assunção, 2006). Além disso, aspectos estruturais e relacionais do cotidiano docente, como demandas laborais intensas, fragilidade no suporte institucional e dinâmicas sociais complexas, contribuem para o agravamento do sofrimento psicológico entre docentes (Brasil *et al.*, 2016).

De acordo com Teixeira (2025), as transformações nas relações laborais da sociedade e o aumento da superexploração dos docentes contribuem diretamente para o adoecimento mental e o desenvolvimento de transtornos mentais. Esse cenário intensifica diversas dimensões do sofrimento psíquico, abrangendo sintomas depressivos, manifestações relacionadas ao estresse prolongado, sentimentos de solidão e outras formas de vulnerabilidade emocional. Vedovato e Monteiro (2008) e Moreno-Jiménez *et al.* (2002) destacam que há uma relação significativa entre a saúde dos docentes e suas condições de vida e trabalho no contexto brasileiro. Além disso, acrescentam que os docentes enfrentam múltiplos desafios psicossociais, incluindo fatores de estresse vinculados à organização escolar e acadêmica, bem como situações cotidianas que muitas vezes não correspondem às expectativas profissionais e pessoais, contribuindo para o desgaste emocional desses trabalhadores.

A pandemia de COVID-19 em 2020 exacerbou desafios pré-existent, principalmente a falta de tempo para atividades de lazer e convívio familiar (Costa *et al.*, 2024). De fato, Campos e Viegas (2021) afirmam que, apesar de a sobrecarga de trabalho e a diminuição da autonomia afetarem o trabalho docente há muito tempo, processos de intensificação do trabalho têm assumido novas características, com repercussões importantes, especialmente, para a saúde mental dos docentes. A necessidade de adaptação rápida e indesejada imposta pelo período pandêmico agravaram a prevalência de sofrimento mental, sendo a educação uma das áreas mais impactadas, onde as aulas presenciais foram

interrompidas e o ensino remoto emergencial foi implementado de forma de súbito para dar continuidade ao ano letivo. De maneira abrupta, os docentes tiveram que adaptar seus conteúdos e aulas presenciais para plataformas online, fazendo uso das tecnologias digitais, sem qualquer preparação prévia. Dessa forma, esse contexto colaborou para o surgimento de adoecimento mental desses profissionais (Rondini *et al.*, 2020). O cenário pandêmico impôs aos docentes dos diferentes níveis educacionais uma profunda reorganização de suas rotinas de trabalho. A ausência de barreiras entre o trabalho e a vida familiar no contexto doméstico exigiu improvisações para a realização das atividades laborais, resultando em impactos negativos sobre a saúde. Somado a isso, o ritmo acelerado imposto pelas transformações tecnológicas, organizacionais e sociais intensifica as demandas de trabalho, reduz a interação afetiva e favorece um ambiente altamente competitivo, propenso a gerar conflitos sociais e emocionais (Pinho *et al.*, 2021; Luz; Kaefer, 2022). Mesmo antes da pandemia, já se observava que o professor em modalidade à distância desempenha funções semelhantes às do ensino presencial, mas enfrenta demandas adicionais próprias do ensino a distância, o que amplia sua exposição a condições adversas e reforça a necessidade de investigar e aprimorar o ambiente e as práticas de trabalho docente (Borges; Santos; Pinto, 2022; Borges; Araújo; Oliveira, 2022). O objetivo geral da tese foi avaliar a saúde mental de docentes do ensino básico em uma perspectiva comparativa com a do superior do Brasil, considerando a prevalência de sintomas depressivos e de TEPT, bem como níveis de otimismo e solidão. Os objetivos específicos foram: a) investigar diferentes dimensões da saúde mental de docentes brasileiros, incluindo indicadores de depressão, TEPT, solidão e otimismo, abrangendo profissionais da educação básica e do ensino superior; b) aprofundar o estudo sobre a prevalência de provável diagnóstico de depressão entre docentes do ensino básico, considerando o impacto de gênero, raça e parentalidade.

A partir das considerações feitas e diante do cenário apresentado, a tese busca responder à seguinte questão de pesquisa: "Qual é a situação da saúde mental de docentes do ensino básico e superior no Brasil, a partir da análise de sintomas de depressão e TEPT, dos sentimentos de solidão e otimismo e dos fatores sociodemográficos associados?". A seguir da tese está estruturada em sete capítulos. No Capítulo 2, apresentamos uma revisão da literatura contemplando os seguintes eixos: 2.1 – Docentes da educação básica: condições laborais e saúde mental; 2.2 – Docentes do ensino superior: desafios profissionais e bem-estar docente; 2.3 – A pandemia como fator agravante do adoecimento mental dos docentes; 2.4 – Depressão como transtorno mental prevalente na docência; 2.5 – Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) entre docentes: evidências e impactos; 2.6 – Solidão na docência: perspectivas e

implicações profissionais e 2.7 – Otimismo na atividade docente: contribuições para o bem-estar e para a prática profissional. O Capítulo 3 descreve o percurso metodológico adotado. No Capítulo 4, é apresentado o primeiro artigo, referente às análises das escalas de depressão, TEPT, solidão e otimismo entre docentes da educação básica e do ensino superior, submetido à *Doxa: Revista Brasileira de Psicologia e Educação*. O Capítulo 5 traz o segundo artigo, publicado na revista *Frontiers in Education*, que aborda os resultados das análises sobre depressão entre docentes da educação básica. O Capítulo 6 apresenta uma discussão geral. Por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões deste trabalho.

2 SAÚDE MENTAL: DESAFIOS NO ENSINO BÁSICO E SUPERIOR

2.1 DOCENTES ENSINO BÁSICO

Nos últimos anos, o ensino básico brasileiro tem passado por transformações significativas que impactam diretamente o trabalho docente, ampliando demandas e exigindo constantes adaptações frente aos avanços tecnológicos e às mudanças sociais que adentram o ambiente escolar (Nascimento; Seixas, 2020). Nesse contexto, as condições de trabalho e a natureza das atividades docentes favorecem o surgimento do esgotamento físico e psicológico, o que pode comprometer metas de ensino, o clima escolar e a qualidade do processo educativo, além de gerar consequências como baixo desempenho profissional, problemas de saúde e prejuízos aos estudantes (Li *et al.*, 2020).

Estudos indicam que frustrações, angústias e o excesso de atividades exercem impactos negativos na vida pessoal dos docentes, dificultando práticas de autocuidado e contribuindo para o sofrimento mental (Cunha *et al.*, 2024). Os transtornos mentais figuram entre os principais problemas de saúde que afetam professores do ensino básico, sendo frequentemente associados à elevada carga de trabalho, à intensificação das exigências laborais e à pressão por produtividade (Santos; Marques; Nunes, 2012; Santos; Taborda; Freitas, 2021). Observa-se um aumento expressivo das licenças-saúde entre profissionais da educação, com predomínio do adoecimento mental como causa de afastamento, sendo que esse quadro está associado a fatores como acúmulo de funções, excesso e ritmo acelerado de trabalho, tempo insuficiente para as tarefas, repetitividade das atividades, conflitos interpessoais e falta de reconhecimento profissional (Godoy, 2025). Nesse contexto, tem sido apontada elevada prevalência de transtornos mentais entre docentes da educação básica, indicando que esse grupo profissional apresenta níveis expressivos de sofrimento psíquico e que docentes frequentemente não identificam ou não relatam adequadamente seus sintomas, o que dificulta o acesso aos serviços de saúde e contribui para a subnotificação dos agravos mentais, evidenciando a necessidade de ações preventivas e de promoção da saúde voltadas especificamente ao adoecimento docente (Baldaçara *et al.*, 2015). Agravando este cenário já preocupante, soma-se o relato frequente de docentes que enfrentam preconceito em relação às doenças mentais, resultando em rejeição por parte de colegas e gestores. Essa estigmatização contribui para o agravamento do quadro clínico e pode levar ao adiamento do tratamento, por receio de retaliações e discriminação, além disso o ambiente externo também exerce influência, especialmente em escolas situadas em comunidades marcadas pela violência, o que

gera um constante sentimento de ameaça no local de trabalho, tal realidade evidencia a ausência de condições minimamente adequadas para o exercício da atividade docente (Moreira; Rodrigues, 2018). Dejours (1992) afirma que a forma como o trabalho está estruturado pode levar o corpo a manifestar o sofrimento gerado pelas exigências laborais, especialmente quando as pressões impedem o trabalhador de regular psicologicamente suas tensões. Marinho e Albuquerque (2024) apontam que a desvalorização do trabalho docente, marcada por exigências excessivas, violência escolar e falta de qualificação, produz exaustão emocional e pode levar ao adoecimento, evidência que dialoga com estudos que associam a fadiga emocional a fatores intrínsecos e extrínsecos ao trabalho docente, como precariedade das condições laborais, baixos salários, excesso de alunos, jornadas extensas, múltiplos vínculos e deslocamentos, impactando negativamente a saúde emocional (Silva *et al.*, 2022; Souza; Coutinho, 2018; Guerreiro *et al.*, *et al.*, 2016). Nesse sentido, a literatura reforça que a precarização do trabalho, a elevada carga física e mental, a falta de reconhecimento social e as múltiplas formas de exploração laboral estão associadas à alta prevalência de sofrimento e distúrbios psíquicos entre docentes, configurando a profissão como uma das de maior risco para sofrimento mental e baixa satisfação no trabalho, com um perfil de vulnerabilidade determinado por variáveis psicossociais do contexto laboral (Neves; Silva, 2006; Albuquerque, *et al.*, 2018; Rodrigues *et al.*, 2019; Trevisan *et al.*, 2022).

Brito *et al.* (2014) sugerem que o sofrimento mental dos docentes não se deve somente à sobrecarga de trabalho, mas da insegurança em relação às finalidades e perspectivas do trabalho docente, devido às dificuldades encontradas em um cenário caracterizado por uma grande lacuna no nível de escolaridade dos alunos, o que gera incertezas sobre os objetivos do ensino e os desafios enfrentados pelos docentes. De fato, esse cenário torna-se mais preocupante quando os próprios colegas de trabalho se tornam fiscalizadores, ridicularizando a enfermidade e promovendo o individualismo, tendo como resultado o enfraquecimento do apoio coletivo (Bottega; Pedroso, 2019). A saúde mental dos docentes desempenha um papel crucial na qualidade do ensino e no bem-estar dos alunos, criando uma ligação entre o ambiente educacional e o desenvolvimento acadêmico e emocional dos estudantes, tornando urgente a promoção de uma cultura organizacional que valorize a saúde mental dos docentes por meio de políticas públicas que ofereçam suporte adequado (Possa; Krause, 2023). Tendo em vista que saúde e educação são condições fundamentais para o desenvolvimento humano e social, é preciso um olhar diferenciado para os docentes, pois as exigências atuais requerem competência pedagógica, social e emocional e estimular a construção crítica dos sujeitos a viver em sociedade como atores participativos,

mas para isso é fundamental que esses profissionais tenham saúde física e mental (Diehl; Marin, 2016).

2.2 DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR

A saúde mental dos docentes do ensino superior está diretamente relacionada às condições de trabalho, especialmente em contextos institucionais que priorizam resultados e produtividade em detrimento do bem-estar desses profissionais, o que tende a agravar o sofrimento psíquico (Aguiar *et al.*, 2024). Evidencia-se um expressivo comprometimento da saúde mental nesse grupo, com mais de 25% dos docentes apresentando sinais sugestivos de transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão, evidenciando a magnitude do problema no contexto universitário (Campos; Vêras; Araújo, 2020). Nesse sentido, destaca-se a necessidade de um olhar atento para a saúde mental dos docentes do ensino superior, sobretudo em relação à incidência de depressão, uma vez que essa condição pode comprometer as relações com alunos, gestores e com a própria instituição de ensino, afetando o desempenho profissional e o ambiente acadêmico (Batista *et al.*, 2016). O ambiente de trabalho exerce papel central no adoecimento mental desses profissionais, sendo influenciado por fatores como sobrecarga laboral, pressões inerentes à profissão, limitadas possibilidades de progressão na carreira, questões salariais e condições precárias de trabalho, elementos que, de forma recorrente, contribuem para o sofrimento psíquico (Quadros Niza *et al.*, 2025).

Uma parcela significativa dos docentes universitários apresenta sintomas de sofrimento mental associados a fatores sociodemográficos e ao exercício da docência em mais de uma instituição, o que reforça a necessidade de valorização da saúde mental desses profissionais no âmbito institucional (Freitas *et al.*, 2021). Corroborando essa perspectiva, o sofrimento docente não decorre exclusivamente de fragilidades individuais ou de situações pontuais, mas constitui resultado de um modelo organizacional que produz e perpetua formas estruturadas de adoecimento, tanto no plano material quanto simbólico (Paiva *et al.*, 2025). Diversos fatores impactam a saúde mental dos docentes do ensino superior, como o ambiente de alta pressão, a cultura e as políticas institucionais, a incerteza quanto à progressão profissional, a instabilidade das disciplinas, o desinteresse discente e o exercício de funções de gestão, aspectos que podem contribuir para o estresse e o desenvolvimento de sintomas depressivos (Soares; Rosseto, 2022). Ademais, o ambiente acadêmico caracteriza-se por demandas elevadas e desafios constantes, favorecendo o sofrimento emocional dos docentes, bem como pela presença de estigmas relacionados à busca de apoio em saúde mental,

frequentemente reforçados pela competitividade e pelo individualismo predominantes nesse contexto (Lima; Vecchi; Paloski, 2024). Nesse sentido, o adoecimento mental dos docentes do ensino superior não se restringe a fragilidades individuais, mas reflete um sistema educacional que, de forma contínua, negligencia condições humanas essenciais ao pleno exercício da docência, tornando a saúde mental uma demanda central e urgente nos debates sobre a qualidade da educação (Augusto; Silva; Aiello, 2025). A intensificação do trabalho acadêmico, marcada por múltiplas e crescentes exigências, tem gerado elevados níveis de pressão e desgaste entre docentes universitários, em um contexto cada vez mais orientado pela produtividade, afetando relações pedagógicas e interpessoais e contribuindo para processos de adoecimento mental (Santana; Mendes, 2025).

2.3 A PANDEMIA COMO FATOR AGRAVANTE DO ADOECIMENTO MENTAL DOS DOCENTES

Em 2020, em decorrência da Pandemia de COVID-19, as atividades educativas sofreram adaptações abruptas e necessárias, para que as medidas sanitárias de prevenção fossem alcançadas, exigindo ainda mais desses profissionais. Dessa forma, o esgotamento emocional se agravou, sendo necessário rever as práticas e procurar opções para atender as demandas da nova rotina e ainda manter a saúde mental (Pereira *et al.*, 2020). O trabalho do profissional docente foi intensificado em decorrência da Pandemia de SARS-CoV-2, que trouxe um cenário completamente diferente para a humanidade. Werneck e Carvalho (2020) contextualizam:

[...] tem se apresentado como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste século. [...] O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua alta velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes em populações vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam as melhores estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da epidemia em diferentes partes do mundo. No Brasil, os desafios são ainda maiores, pois pouco se sabe sobre as características de transmissão da COVID-19 num contexto de grande desigualdade social, com populações vivendo em condições precárias de habitação e saneamento, sem acesso sistemático à água e em situação de aglomeração (Werneck; Carvalho, 2020).

O Ensino Remoto ganhou protagonismo nesse momento de crise, colocando todas as instituições educacionais frente aos desafios de construção de novas formas de ensino-aprendizagem, ressignificando as práticas pedagógicas (Valente *et al.*, 2020). A carga dedicada ao trabalho exigida pelos docentes foi acima da contratada, isto é, o ensino remoto demandou maior dedicação, bem como, observou-se que houve um nível significativo de

aprendizado docente em relação à utilização das tecnologias digitais que foram incorporadas às práticas pedagógicas durante a pandemia (Ramos *et al.*, 2023).

De acordo com Alves, Martins e Moura (2021), os docentes do ensino básico apresentaram sintomas depressivos demonstrando que as aulas online trouxeram uma carga de trabalho maior do que o esperado, entrelaçado por momentos de constantes inquietações pelo contexto de inseguranças provocadas pela pandemia. Isso resultou em uma variedade de sentimentos, como tristeza, estresse e insônia, e o acúmulo dessas emoções contribuiu para o surgimento de quadros de ansiedade e depressão (Santos *et al.*, 2024). Entre os fatores associados a esses desfechos, destaca-se a dificuldade na adoção de ferramentas tecnológicas durante a transição abrupta do ensino presencial para o ensino remoto no contexto do distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19, o que acarretou uma sobrecarga de trabalho docente, inclusive entre aqueles com familiaridade com recursos de informática, evidenciando não apenas desafios técnicos, mas também incertezas quanto às metodologias da educação a distância, mesmo quando implementadas de forma emergencial (D'Angelis *et al.*, 2024).

Segundo Cecílio e Nascimento (2023), observa-se que os problemas de saúde mental enfrentados pelos docentes já existiam antes da pandemia, no entanto, esses desafios foram intensificados pelas transformações no comportamento social que ocorreram em decorrência da COVID-19, alterando profundamente as dinâmicas sociais. Agravando ainda mais a necessidade de repensar o modelo educacional, buscando alternativas que valorizem o trabalho docente e promovam a saúde mental dos professores (Barbosa *et al.*, 2024). De acordo com Zottele e Rocha (2024), ao retomar as atividades presenciais num cenário com características diferentes de antes da pandemia, a saúde mental dos docentes foi afetada, pois o mundo se transformou e há muitas dificuldades em engajar os alunos nos conteúdos.

2.4 DEPRESSÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a depressão como um transtorno mental comum que afeta mais de 280 milhões de pessoas em todo o mundo, correspondendo a aproximadamente 5,7% da população adulta, com maior prevalência entre mulheres do que entre homens, além de figurar entre as principais causas de incapacidade global (OMS, 2023; 2025). A depressão caracteriza-se por tristeza persistente, perda de interesse ou prazer em atividades habituais, sensação de culpa ou baixa autoestima, distúrbios do sono e do apetite, cansaço e dificuldade de concentração (OMS, 2023). A Organização Pan-Americana da Saúde

(2018) complementa essa definição ao classificá-la como um distúrbio que compromete de forma significativa a vida diária, interferindo em atividades como dormir, estudar, comer, trabalhar e desfrutar do lazer. A doença pode ser recorrente e afetar negativamente o desempenho escolar, profissional e os relacionamentos interpessoais. A depressão, enquanto transtorno mental e comportamental, figura entre as principais causas de afastamento de docentes do ensino básico no Brasil, estando fortemente associada à concessão de licenças médicas (Silva; Vieira, 2022). Esse quadro pode estar relacionado às elevadas demandas enfrentadas pelos profissionais da educação, que exigem maior tolerância e resiliência, tornando-os mais vulneráveis a problemas de saúde mental (Ferreira-Costa; Pedro-Silva, 2019). A precarização do trabalho, que afeta a maioria das escolas, juntamente com a violência no ambiente escolar e a sobrecarga de atividades, têm favorecido o adoecimento mental e a depressão se destaca como a principal patologia decorrente da profissão (Soares; Oliveira; Batista, 2017). O surgimento de sintomas depressivos é influenciado por diversos fatores, incluindo idade, insatisfação com o trabalho, estilo de vida pouco saudável e bem-estar. Portanto, a sociedade pode encarar o adoecimento a partir desses motivos, incentivando cada vez mais o reconhecimento do trabalho e evitando incertezas nas atividades docentes (Vieira *et al.*, 2023; Moreira, 2019). Além de ser causada por fatores referentes ao trabalho, a depressão pode ser atribuída a uma condição prévia do trabalhador agravada ou desenvolvida pelo contexto laboral em específico (Brun; Monteiro, 2020). De fato, o consumo de antidepressivos por docentes é consideravelmente alto e esta prevalência elevada de depressão pode estar relacionada ao estresse, estado de tensão, ansiedade, depressão e carga elevada de trabalho (Segat; Diefenthaler, 2013). Um estudo com a população mexicana revelou prevalências mais altas de depressão grave entre docentes mexicanos em relação à população em geral, e cerca de 80% desses profissionais não receberam tratamento farmacológico, sugerindo falta de acesso a serviços de saúde ou subdiagnóstico de transtornos mentais (Soria-Saucedo *et al.*, 2018).

A ocorrência de depressão decorre da interação entre fatores individuais, sociais e contextuais, que podem intensificar ou atenuar a manifestação de sintomas, o que torna fundamental compreender como características pessoais, condições de trabalho e dinâmicas relacionais se articulam na explicação desse fenômeno. De acordo com o IBGE (2019), há uma maior prevalência de depressão em mulheres (14,7%) em relação aos homens (5,1%, 2,8 vezes mais). Ainda segundo o IBGE (2019), ao se analisar o período de 2013 a 2019, observa-se que a proporção de pessoas que relataram diagnóstico de depressão aumentou ligeiramente mais entre as mulheres (35%) do que entre os homens (31%). Esse padrão também se manifesta no contexto do trabalho docente, uma vez que Segat e Diefenthaler (2013), ao investigarem professores de diferentes redes de ensino, identificaram elevada prevalência do uso de medicamentos antidepressivos, particularmente entre mulheres, evidenciando um quadro relevante de adoecimento mental, sendo essa maior prevalência no sexo feminino apontada pelos autores como possivelmente associada a múltiplos fatores. De forma convergente, Costa *et al.* (2024) e Ribas *et al.* (2025) apontam a existência de uma disparidade de gênero no sofrimento mental, com implicações específicas para as docentes, que enfrentam desafios sociais adicionais no exercício da profissão. De forma mais específica, Barreto e Hissa (2020) indicam que aproximadamente 67% dos docentes do ensino básico identificados com adoecimento mental pertencem ao gênero feminino, apresentando diferentes graus de sintomas depressivos conforme o Inventário de Depressão de Beck (BDI), achado que tem sido associado às múltiplas jornadas de trabalho docente combinadas às responsabilidades familiares, fatores que influenciam direta e desfavoravelmente a saúde do gênero feminino. Um estudo português de Gomes e Quintão (2011) destacou que docentes com uma maior carga horária apresentaram mais sintomas de depressão e evidenciou a relação da sintomatologia ao gênero feminino. Barros *et al.* (2019) ao analisar o banco de dados informatizado do setor de perícia médica da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) em Aracaju (SE), correspondentes aos prontuários dos servidores que se submeteram à perícia com o intuito de se afastar do trabalho, verificou que houve maior prevalência de depressão nas docentes mulheres (90,8%), sendo a principal causa de afastamento dos docentes. Além disso, mais da metade dos profissionais apresentou reincidência. Segundo Ribeiro *et al.* (2023), um elevado número de docentes são acometidos por ansiedade e depressão, sendo que as mulheres são mais afetadas. Souza e Silva *et al.* (2024) em seu estudo com docentes do ensino básico em Minas Gerais, afirmam que as mulheres são mais propensas a ter depressão e ansiedade devido vários fatores como: carga horária excessiva, dificuldade com o trabalho remoto, insatisfação com o trabalho, problemas

relacionados ao sono, entre outros. Lima *et al.* (2024) corroboram que há uma elevada prevalência de depressão entre docentes do ensino fundamental, em seu estudo apontaram como possíveis fatores: gênero, maior carga horária de trabalho com alunos, ausência de liberdade na gestão de suas atividades laborais, entre outros. Moraes Cruz *et al.* (2020) afirmam que as alterações na saúde mental mais frequentes nos docentes encontradas no seu estudo foram a ansiedade e a depressão, sendo que as docentes apresentam maiores chances de desenvolver estes problemas.

Para além do gênero, outros marcadores sociais também influenciam a incidência da depressão, tornando insuficiente qualquer análise que considere esse fator de forma isolada. Aspectos como a raça atravessam a experiência do sofrimento psíquico e produzem vulnerabilidades diferenciadas entre os sujeitos. Nesse sentido, a raça destaca-se como um marcador central, sobretudo quando se analisam os efeitos das desigualdades estruturais e das experiências recorrentes de discriminação racial sobre a saúde mental. A depressão configura-se como um dos efeitos mais significativos das experiências recorrentes de discriminação racial sobre a saúde mental da população negra, resultando de processos contínuos de exclusão, violência simbólica e desigualdade estrutural (Gouveia Damasceno; Zanello, 2018). Martins e Santos (2023) corroboram essa perspectiva ao ressaltarem que, para além das desigualdades socioeconômicas e da baixa qualidade dos serviços de saúde destinados à população negra, a depressão apresenta estreita relação com o comportamento suicida, o caráter hereditário dos transtornos depressivos e a ausência de políticas públicas eficazes, configurando-se como uma ameaça concreta à vida da pessoa negra. Adicionalmente, evidências indicam que, em situações de trabalho com menor exposição a estressores ocupacionais, a raça, de forma isolada, pode resultar em maiores prejuízos à saúde mental do que o gênero.

No que se refere à parentalidade, embora ainda sejam escassos os estudos que investiguem diretamente a parentalidade e a depressão no contexto da docência, a literatura sobre saúde mental docente indica que fatores familiares, incluindo o conflito trabalho-família, constituem importantes determinantes do sofrimento psíquico e da depressão entre professores (Zhong; Hu; Xu, 2025).

A literatura aponta que as flutuações nas condições de saúde mental associadas ao exercício das funções parentais tendem a ser mais pronunciadas entre as mulheres do que entre os homens, refletindo a distribuição desigual das responsabilidades de cuidado na organização social contemporânea (Metzger; Gracia, 2023). Isso mostrou-se realidade também na academia, onde mães enfrentam um risco maior de depressão do que mulheres sem filhos e do que os pais, com fatores específicos contribuindo para essa maior vulnerabilidade, em especial raça e a maternidade de filhos com deficiência (Rocha *et al.*, 2025).

2.5 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

O TEPT, segundo a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2013) pertence à categoria de Transtornos Relacionados a Trauma e Estressores, que abrange condições que exigem a exposição a um evento traumático ou estressante para o diagnóstico. Para preencher os critérios diagnósticos para o TEPT, o indivíduo deve ter sido exposto a um evento potencialmente traumático, seja vivenciando diretamente ou testemunhando este evento, ou de maneira indireta, ao saber que pessoas próximas foram afetadas por ele (APA, 2013). Os principais sintomas do TEPT incluem a revivescência do trauma, a evitação persistente de estímulos associados ao evento, alterações negativas nas cognições e no humor, além de hiperexcitabilidade. Tais manifestações devem gerar sofrimento clinicamente significativo e prejuízos substanciais no funcionamento social, ocupacional e em outras áreas importantes da vida (APA, 2013). O TEPT apresenta prevalência estimada entre aproximadamente 1% e 14% em populações urbanas de diferentes países, conforme estudos epidemiológicos internacionais, podendo alcançar entre 40% e 80% das pessoas expostas a traumas graves (Blanco; Canto-de-Souza, 2018). A prevalência ao longo da vida do TEPT é considerada elevada, sendo mais frequente entre mulheres, apresentando ainda forte comorbidade com outros transtornos ao longo da vida, com evidências de que mais de um terço dos indivíduos acometidos não se recupera mesmo após muitos anos (Kessler *et al.*, 1995). Em um estudo realizado no Brasil durante a pandemia de COVID-19 com membros da comunidade acadêmica, Lana *et al.* (2026) observaram que 21,3% (n = 253) dos participantes apresentaram escores acima do ponto de corte, indicando provável diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), entre os diferentes grupos analisados, evidenciou-se que 13,45% dos docentes apresentaram provável diagnóstico de TEPT. A literatura aponta uma

prevalência de TEPT em torno de 11%, com elevação durante a pandemia de COVID-19, quando, por exemplo, alcançou 24,5% entre docentes universitários na China (Mondragon *et al.*, 2023). A pandemia de COVID-19 constituiu um evento de estresse prolongado que envolveu não apenas a ameaça direta da doença, mas também um conjunto de estressores secundários que podem ter atuado como potenciais fatores de vulnerabilidade para sintomas de TEPT, como isolamento social, ruptura de rotinas, exposição intensa a notícias alarmantes, dificuldades econômicas e, em alguns casos, hospitalização (Bridgland *et al.*, 2021; Villatoro *et al.*, 2022; Janiri *et al.*, 2021). No Brasil, esse cenário foi agravado pelo colapso do sistema de saúde, profundas desigualdades sociais (The Lancet, 2020; Fiocruz, 2021) e intensa instabilidade política, com disseminação de desinformação e mensagens governamentais conflitantes que comprometeram a adesão às medidas de proteção (Camacho *et al.*, 2024). No ambiente educacional, a transição emergencial para o ensino remoto expôs de forma crítica desigualdades de infraestrutura digital e exigiu adaptação rápida sem treinamento tecnológico (Gusso *et al.*, 2020), especialmente nos docentes em contato mais direto com estudantes em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, estudos prévios mostraram altas taxas de provável TEPT entre profissionais universitários (Goldstein *et al.*, 2023; Mallhi *et al.*, 2023; Lana *et al.*, 2026). Fan *et al.* (2021) avaliaram o TEPT em professores universitários de Wuhan um mês após o fim do isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19 e observaram que aproximadamente um quarto desses docentes desenvolveu o transtorno, sendo a incidência entre docentes diagnosticados com COVID-19 2,8 vezes maior do que entre aqueles sem sintomas e cerca do dobro da observada em indivíduos com gripe confirmada e sintomas leves.

2.6 SOLIDÃO

A solidão é compreendida como uma experiência subjetiva e desagradável que ocorre quando há uma discrepância entre as relações sociais desejadas e aquelas efetivamente vivenciadas pelo indivíduo (Peplau; Perlman, 1982). Diferente de estar fisicamente só, a solidão refere-se à percepção subjetiva de desconexão emocional, caracterizada pela discrepância entre as relações sociais desejadas e aquelas efetivamente percebidas (Cacioppo *et al.*, 2014; Cacioppo *et al.*, 2015; Leigh-Hunt *et al.*, 2017). Essa experiência subjetiva de isolamento emocional tem sido amplamente reconhecida como fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento e agravamento de problemas de saúde mental e física, incluindo sintomas depressivos, distúrbios do sono, alterações cardiovasculares, maior risco de morbidade e

mortalidade (Hawkley; Cacioppo, 2010). No contexto do trabalho docente, a solidão tem sido apontada, de modo geral, como um fator que compromete significativamente o desempenho profissional, estando associada à redução da autoconfiança, ao enfraquecimento da motivação para o ensino e à limitação da criatividade na elaboração das aulas, além de intensificar sentimentos de estresse, nervosismo e ansiedade e ampliar a frustração decorrente da falta de interação, comunicação e engajamento no ambiente escolar (Telyani; Farmanesh; Zargar, 2021).

Corroborando esses achados, Neto (2015), em pesquisa realizada com 1.194 docentes do ensino básico, identificou que níveis mais elevados de solidão estão associados a maior insatisfação com o trabalho docente. No contexto específico da pandemia de COVID-19, tais impactos mostraram-se ainda mais evidentes. Demartini, Amaral-Rosa e Cerutti (2023) destacam que, embora os docentes tenham apontado algumas estratégias para enfrentar os desafios relacionados à interação nas aulas on-line, a superação dessas dificuldades não se mostrou simples, uma vez que o ensino mediado por computador alterou significativamente a dinâmica das aulas presenciais, especialmente no que se refere ao contato físico, à comunicação não verbal e às interações simultâneas e coletivas, características centrais do ambiente escolar. De forma semelhante, González-García, Fuentes e Renobell (2025), ao investigarem docentes da educação básica e superior, observaram que perfis com patamares moderados de motivação para o trabalho docente apresentaram níveis mais elevados de solidão percebida, apesar de relatarem maior satisfação com o ensino e afetos positivos, resultado que os autores relacionam ao isolamento social imposto pelo confinamento e ao maior envolvimento emocional com o trabalho durante a pandemia.

2.7 OTIMISMO

O otimismo é definido como uma expectativa generalizada de que acontecimentos positivos ocorrerão no futuro, constituindo um traço disposicional relativamente estável que influencia a forma como os indivíduos interpretam e enfrentam as adversidades (Scheier; Carver, 1985). No contexto educacional, o otimismo exerce um papel mediador na relação entre a saúde organizacional e as diferentes dimensões da saúde docente, atuando como um fator de proteção ao auxiliar os docentes no enfrentamento dos desafios do ambiente de trabalho, atenuando os efeitos negativos associados a contextos organizacionais fragilizados e promovendo o bem-estar geral (Borrallho *et al.*, 2025). Evidências também indicam que a

esperança e o otimismo configuram-se como recursos psicológicos fundamentais, atuando simultaneamente na promoção do bem-estar docente e na proteção contra o burnout, sendo o otimismo o fator que exerce influência mais robusta na redução desse quadro e, conseqüentemente, na elevação do bem-estar (Taati Jeliseh *et al.*, 2025). Além disso, docentes com níveis elevados de otimismo intelectual, compreendido como uma crença positiva e realista na própria capacidade intelectual, profissional e pedagógica para lidar com desafios cognitivos, institucionais e educacionais, mesmo em contextos adversos, tendem a planejar suas atividades pedagógicas de forma alinhada aos objetivos institucionais, adotar estratégias de enfrentamento mais adaptativas e apresentar maior probabilidade de permanência na carreira docente (Song, 2022).

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento do estudo, de modo a atender aos objetivos propostos.

A tese faz parte do Projeto PSICovidA, coordenado pelo Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento (LABNeC) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e realizado em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense (CAAE 52739721.0.0000.5243).

3.1 INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS

Para coleta de dados, foi empregado um questionário online, contendo uma seção sociodemográfica, que abordou informações como gênero, raça, vínculo acadêmico e a presença de filhos. No caso de os participantes indicarem que tinham filhos, foram automaticamente direcionados para perguntas específicas sobre parentalidade. Após a seção demográfica, foram apresentados instrumentos psicométricos para avaliação de diferentes aspectos da saúde mental. Não havia tempo limite para o preenchimento do questionário, mas, de uma forma geral, o tempo médio de preenchimento era de 25 minutos. O questionário completo está apresentado no Anexo I.

Para avaliar a depressão, empregou-se o *Patient Health Questionnaire 9* (PHQ-9), uma escala composta por nove itens que avaliam os sintomas de depressão maior, conforme descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV). O PHQ-9 é composto por questões que abordam nove sintomas da depressão, conforme a seguir descrito. 1) Humor deprimido. 2) Anedonia, ou a falta da capacidade em sentir qualquer tipo de prazer, recorrente em estados de depressão grave. 3) Problemas com sono. 4) Cansaço ou falta de energia. 5) Mudança de apetite ou peso. 6) Sentimento de culpa ou inutilidade. 7) Problemas de concentração. 8) Lentidão ou inquietude. 9) Pensamentos suicidas. Os indivíduos respondem ao PHQ-9 sobre a ocorrência dos sintomas acima em uma escala que varia de 0 a 3, em que 0 corresponde a “nenhum dia”, 1 corresponde a “alguns dias”, 2 corresponde a “mais da metade dos dias” e 3 corresponde a “quase todos os dias”. A pontuação total do instrumento é obtida pela soma dos itens, variando de 0 a 27 pontos, sendo que uma

pontuação igual ou superior a 9 indica provável diagnóstico de depressão. A partir das nove questões, é elaborado um indicador-síntese que mede o estado de depressão do respondente. Para gerar o indicador-síntese, a escala de Likert e a teoria clássica dos testes são comumente utilizadas. Essas abordagens consistem na soma das respostas dadas a cada um dos itens. A validação do PHQ-9 foi confirmada em uma amostra da população brasileira por Santos *et al.* (2013).

Neste estudo, são categorizados os participantes como com ou sem um provável diagnóstico de depressão usando um ponto de corte de pontuação 9 ou superior para indicar um provável diagnóstico de depressão. O PHQ-9 é uma escala autoadministrada validada, utilizada para triagem de depressão, devendo ser seguida por uma entrevista clínica para determinar se um paciente realmente tem transtorno depressivo maior quando seus resultados forem sugestivos de depressão (Zimmerman, 2019).

Para medir os sintomas do TEPT, foi empregada a *Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5* – PCL-5, composta de 20 perguntas que medem a gravidade dos 4 grupos de sintomas do Estresse Pós-traumático (revivescência, evitação, alterações de humor e cognições, e hiperexcitabilidade). Foram considerados como prováveis casos de TEPT aqueles que obtiveram pontuação igual ou superior ao ponto de corte de 36, uma vez que a literatura sugere que este ponto de corte proporciona o melhor desempenho diagnóstico para a população brasileira (Pereira-Lima *et al.*, 2019).

Além dos instrumentos para avaliação de depressão e TEPT, foi utilizada a escala que mede a solidão relacionada a isolamento social, ausência de companhia e rejeição por um grupo (*Three-Item Loneliness Scale*; Hughes *et al.*, 2004) que consiste em uma versão abreviada da *UCLA Loneliness Scale*, criada para medir de forma rápida e confiável os sentimentos de solidão percebida e o isolamento social subjetivo, especialmente em pesquisas populacionais de grande escala. A escala é composta por três afirmações: “Com que frequência você sente que falta companhia?”, “Com que frequência você se sente deixado de fora?” e “Com que frequência você se sente isolado dos outros?”, às quais o participante responde em uma escala de três pontos, variando de 1 (raramente ou nunca) a 3 (frequentemente). A soma dos itens resulta em uma pontuação total de 3 a 9, sendo que valores mais altos indicam maior solidão percebida. Por fim, foi avaliado o otimismo vivenciado pelos participantes, através do teste *Life Orientation Test - Revised* (LOT-R), desenvolvido por Carver e Scheier (2003), traduzido e adaptado por Cruz e Gomes, (2007). Esta escala avalia as diferenças pessoais ao nível do otimismo e pessimismo, compreendendo seis itens avaliados numa escala tipo “Likert” de cinco pontos (A=Discordo bastante;

E=Concordo bastante).

3.2 AMOSTRA

Foram convidados para responder ao questionário docentes do Ensino Básico e Superior de todo o Brasil. Os questionários foram divulgados em redes sociais e enviados por e-mail e aplicativos de mensagem. Os participantes recebiam os formulários e eram estimulados a repassar para outras pessoas. Os participantes responderam ao questionário online entre os dias 10 de março e 10 de junho de 2022, período em que o Brasil se encontrava em estágio avançado da campanha de vacinação contra a COVID-19, com foco nas doses de reforço (terceira dose) e, em alguns grupos, no início da aplicação da quarta dose (segunda dose de reforço), sendo importante destacar que, durante esse intervalo, grande parte da população já havia sido vacinada e as atividades escolares haviam retornado ao formato presencial.

Os critérios de inclusão para participação na pesquisa foram ser maior de 18 anos e ser docente do ensino básico e superior das redes pública e/ou privada brasileiras. Consideramos como critério de exclusão os erros no preenchimento do questionário, não aceitação do termo de consentimento e respostas duplicadas. A amostra consistiu em 273 docentes do ensino básico e 1438 docentes do ensino superior.

3.3 ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise estatística, as variáveis contínuas foram descritas por meio da mediana e dos intervalos interquartis (primeiro e terceiro quartil), considerando a distribuição não normal dos dados. Todos os testes estatísticos adotaram nível de significância de $p < 0,05$. As comparações entre grupos foram conduzidas por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney, aplicado aos escores totais das escalas PHQ-9 (sintomas depressivos), PCL-5 (sintomas de transtorno de estresse pós-traumático), Three-Item Loneliness Scale – TILS (percepção de solidão) e *Life Orientation Test – Revised* (LOT-R) (otimismo), de acordo com variáveis demográficas selecionadas. As variáveis demográficas analisadas incluíram gênero, parentalidade e raça/cor. No que se refere à raça/cor, o questionário adotou as categorias propostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): branca, preta, parda, amarela e indígena; para fins analíticos, as categorias preta e parda foram agrupadas sob a denominação “negros”. Além disso, foram calculadas as prevalências de provável depressão e

de provável TEPT com base nos pontos de corte previamente estabelecidos para as escalas PHQ-9 (≥ 9 pontos) e PCL-5 (≥ 36 pontos), respectivamente.

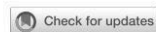
Além das comparações entre grupos, foi conduzida uma análise de regressão logística múltipla para analisar o valor preditivo de diversos fatores na probabilidade de um diagnóstico de depressão. O modelo incluiu gênero, raça (negro vs. branco), parentalidade (ter filhos vs. não ter filhos), presença ou ausência de diagnóstico psiquiátrico prévio e idade (como covariável contínua). As análises foram realizadas utilizando o Sigmaplot 14.0 (SYSTAT Software, Inc.) e o Jamovi versão 2.3.28 (The Jamovi Project, <https://www.jamovi.org>).

5 ARTIGO UNDERSTANDING DEPRESSION IN BASIC EDUCATION TEACHERS: EVIDENCE FROM BRAZIL

Este artigo foi publicado no periódico “*Frontiers in Education*”.



TYPE Original Research
PUBLISHED 09 January 2026
DOI 10.3389/feduc.2025.1669000



OPEN ACCESS

EDITED BY
Sowmini Padmanabh Kamath,
MAHE, Manipal, India

REVIEWED BY
Jackylou Sarsale,
Southern Leyte State University, Philippines
Sphoorthi Prabhu,
Independent Research, Chennai, India

*CORRESPONDENCE
Fernanda Staniscuaski
✉ fernanda.staniscuaski@ufrgs.br

RECEIVED 18 July 2025
REVISED 02 December 2025
ACCEPTED 16 December 2025
PUBLISHED 09 January 2026

CITATION
Santos KCR, Machado AV, Rocha S,
Martins RM, Nudelman M, Pereira MG, de
Oliveira L and Staniscuaski F (2026)
Understanding depression in basic education
teachers: evidence from Brazil.
Front. Educ. 10:1669000.
doi: 10.3389/feduc.2025.1669000

COPYRIGHT
© 2026 Santos, Machado, Rocha, Martins,
Nudelman, Pereira, de Oliveira and
Staniscuaski. This is an open-access article
distributed under the terms of the [Creative
Commons Attribution License \(CC BY\)](#). The
use, distribution or reproduction in other
forums is permitted, provided the original
author(s) and the copyright owner(s) are
credited and that the original publication in
this journal is cited, in accordance with
accepted academic practice. No use,
distribution or reproduction is permitted
which does not comply with these terms.

Understanding depression in basic education teachers: evidence from Brazil

Karen Christina Rodrigues dos Santos¹, Arthur V. Machado²,
Sarah Rocha², Rony Magalhães Martins², Marta Nudelman²,
Mirtes Garcia Pereira², Letícia de Oliveira² and
Fernanda Staniscuaski^{1*}

¹Graduate Program in Science Education, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, ²Graduate Program in Biomedical Sciences (Physiology and Pharmacology), Fluminense Federal University, Rio de Janeiro, Brazil

Introduction: Teacher mental health is a growing global concern, particularly in under-resourced educational systems. Depression among educators compromises not only individual well-being but also the quality and equity of education. This study investigates the prevalence of depressive symptoms among Brazilian basic education teachers and explores how structural inequalities, particularly gender, race, parenthood, and prior psychiatric history, contribute to mental health outcomes.

Methods: A total of 273 teachers from public and private schools across Brazil responded to an online survey including sociodemographic items and the Patient Health Questionnaire 9 (PHQ 9). Statistical analyses included Mann–Whitney tests and multiple logistic regression to compare group differences and estimate predictors of probable depression.

Results: Nearly half of participants (49.5%) scored above the PHQ-9 cutoff for probable depression. Female teachers and those with a history of psychiatric diagnosis were significantly more likely to report depressive symptoms. Black teachers exhibited higher scores and greater proportions above the cutoff. Parenthood showed no significant association with depression in this sample.

Discussion: These findings reveal that the mental health burden among teachers in Brazil is alarmingly high and closely tied to broader structural conditions. The combination of chronic emotional demands, institutional precarity, and intersecting social inequalities places educators, especially women and Black professionals, at heightened risk. These results emphasize the need for systemic policy responses that move beyond individual resilience frameworks and instead address the organizational, social, and racialized dynamics that shape teacher well-being.

Conclusion: This study contributes to the international dialogue on teacher mental health. The findings underscore the urgency of implementing structural interventions and equity-oriented policies that protect educators from cumulative psychological strain. Addressing teacher mental health is not only a matter of individual care but a strategic imperative for the sustainability and inclusivity of education systems worldwide.

KEYWORDS

depression, education, gender, mental health, race, teachers

1 Introduction

Mental health has increasingly become a global concern, especially regarding the effects of occupational stress on psychological well-being. The World Health Organization (WHO) reported a 25% increase in anxiety and depression globally following the COVID-19 pandemic (WHO, 2022). In Brazil specifically, 10.2% of individuals aged 18 or older reported having received a depression diagnosis in 2019, equivalent to approximately 16.3 million people, a 34% increase compared to 2013, when 7.6% of the population reported similar conditions (Instituto Cactus, 2023).

A concerning escalation of mental health challenges among teachers has been observed in recent decades (Ghasemi, 2025). There is a marked rise in mental health issues, including depression, among educators worldwide (Agyapong et al., 2022). Teacher mental health has historically been compromised by intense and complex working conditions. Bureaucracy, poor relationships, and workload are major stress factors that undermine teachers' well-being (Zagni et al., 2025). With the advent of new technologies since the 1990s, these conditions intensified further. During the pandemic, the precariousness of teaching work increased significantly due to extended working hours and the abrupt shift to remote teaching, aggravating psychological distress among educators (Borges J. L. J. et al., 2022; Borges K. et al., 2022). A recent study of basic education teachers in China identified high levels of depression, anxiety, and burnout, underscoring that teacher mental health deterioration is a global phenomenon (He et al., 2025).

While these recent dynamics are striking, they must be interpreted as part of longstanding structural vulnerabilities within the teaching profession. The burnout theory (Maslach and Leiter, 1997) offers critical insights here by framing teachers' mental health deterioration not as isolated incidents but as systemic outcomes of chronic emotional exhaustion, professional disillusionment, and depersonalization. Teaching demands sustained emotional labor and affective engagement, which, under conditions of excessive pressure and lack of institutional support, become unsustainable and even cause physical ill-health in teachers (Madigan et al., 2023). Rather than viewing the emotional suffering of teachers as an exception, burnout theory forces a recognition that it is a predictable and recurrent product of how educational systems are organized. Similarly, the job demands-resources model (Demerouti et al., 2001) deepens this analysis by showing that when the demands placed on teachers consistently exceed the available professional and emotional resources, psychological strain becomes inevitable. Within this model, it is not only the volume of work but the persistent imbalance between expectations and available support that generates adverse mental health outcomes. Recent data from Australia strengthen this interpretation by showing that the effects of high demands on teacher mental health intensify under conditions of declining autonomy, a pattern increasingly observed in contemporary educational systems (Morris et al., 2025). Understanding the experience of teachers through this lens highlights the urgent need to interrogate the structural and organizational dimensions of schooling, rather than attributing psychological outcomes solely to individual resilience or vulnerability.

The prevalence of mental suffering among teachers, notably depression, has substantial implications for both professional

performance and personal well-being, ultimately impacting educational quality and student outcomes (Possa and Krause, 2023). Given these challenges, a detailed exploration of the factors influencing teachers' mental health is essential to developing targeted, effective interventions on a global scale. Basic education teachers in Brazil face work conditions that differ substantially from those in higher education, including larger student groups, lower salaries, limited institutional autonomy, high administrative burden, and closer proximity to community-level social vulnerabilities. These contextual features create a distinct pattern of emotional demands that may shape mental health outcomes differently from those observed in other educational levels. Despite consistent evidence of mental health problems among teachers, few studies have examined how these systemic pressures operate specifically within basic education. Addressing this gap is essential to understand whether the vulnerabilities documented in other educational settings manifest similarly, or whether they assume unique forms in this segment of the workforce. The research questions guiding this study are: What is the probability of depression among basic education teachers in Brazil, and how is it associated with sociodemographic factors? Accordingly, the objectives of the study are (1) to estimate the prevalence of probable depression among basic education teachers in Brazil using the PHQ-9 scale, and (2) to examine how gender, race, parenthood, and prior psychiatric diagnosis are associated with depressive symptoms after adjusting for age. By examining these factors, this study aims to contribute not only to a better empirical understanding of teacher mental health, but also to a critical reassessment of how we theorize the profession itself: not as a neutral vocation, but as a socially and politically constructed space where certain bodies and identities bear disproportionate psychological burdens.

Although burnout theory and the job demands-resources model emphasize systemic mechanisms, these structures are also expressed through differential exposure and vulnerability across social groups. Individual sociodemographic variables such as gender, race, parenthood, and prior mental health history function as markers of how structural pressures become unevenly distributed within the profession. Examining these dimensions therefore allows us to identify which groups are disproportionately affected by system-level stressors, providing an empirical entry point to understand how broader organizational inequalities materialize in teachers' mental health.

2 Challenges of the teaching profession and mental health outcomes

Across various educational systems, teachers experience demanding professional conditions characterized by heavy workloads, emotional exhaustion, inadequate institutional support, and difficulties maintaining a healthy work-life balance (UNESCO, 2024; Sabagh, et al., 2018; Watts and Robertson, 2011). Challenging work conditions can have impacts on a teacher's wellbeing with physical, psychological, emotional, and social dimensions. A common source of stress for teachers is the lack of a healthy work-life balance (UNESCO, 2024). According to Sabagh et al. (2018), these stressors not only contribute to burnout but also compromise teachers' overall well-being, leading to severe mental health outcomes like depression and anxiety.

The theoretical frameworks of burnout and the job demands-resources model are particularly relevant in illuminating how these conditions interact over time. Burnout theory stresses that emotional exhaustion is often accompanied by growing feelings of cynicism and loss of professional purpose, a progression especially visible among educators who are continuously exposed to unrelenting demands with little institutional validation (Maslach and Leiter, 1997). Meanwhile, the job demands-resources model suggests that while job demands such as workload and emotional strain are inevitable in education, their deleterious effects are significantly mitigated, or exacerbated, by the presence or absence of supportive resources (Demerouti et al., 2001). Thus, the deterioration of teacher mental health must be seen not as a side effect of the job, but as a structural consequence of systemic underinvestment in the emotional and material support of educational workers.

Studies conducted in Brazil indicate a significant relationship between teachers' mental health and their living and working conditions (Vedovato and Monteiro, 2008). Brazilian teachers frequently encounter psychosocial stressors associated with dissatisfaction towards academic and institutional structures and unfulfilled personal expectations regarding daily work (Moreno-Jimenez et al., 2002). Depression is not only caused by work-related factors but can also be attributed to a pre-existing condition of the worker, exacerbated or developed by the specific work context (Brun and Monteiro, 2020). The inverse relationship between job satisfaction and depression highlights the importance of fostering a supportive work environment and positive personal relationships to mitigate mental health risks (Silva et al., 2018). Such findings suggest that any effective response to the crisis of teacher mental health must confront not only the symptoms but also the broader organizational pathologies that normalize emotional suffering within the profession.

2.1 Factors influencing depression among teachers

Multiple intersecting factors significantly influence depression risk among teachers. In Brazil, teachers report high levels of emotional distress linked explicitly to excessive workloads and unfavorable work environments, with women disproportionately affected (Ribeiro et al., 2023). Consistent with broader population trends, women teachers frequently report higher depression rates than their male counterparts, reflecting gender-based inequalities in occupational and societal roles (Maggioni et al., 2008; Mendes Rodrigues et al., 2019; Tostes et al., 2018). The intersection of gender and professional demands resonates with arguments from work-family conflict theory (Greenhaus and Beutell, 1985), which contends that competing demands from home and work create chronic stress, especially in professions heavily feminized like teaching. Far from being isolated struggles, these tensions reveal systemic inequalities in the allocation of emotional and caregiving labor, both within households and within schools themselves.

Racial discrimination further compounds vulnerabilities to depression, as Black teachers experience disproportionate psychological distress stemming from systemic inequalities and discrimination within educational institutions (Gouveia Damasceno and Zanello, 2018). Critical race theory (Delgado and Stefancic, 2017) pushes this analysis further by arguing that racism is not an

aberration but a constitutive element of social institutions, including schools. Evidence from higher education in Brazil reinforces this perspective, showing that Black mothers in academia are significantly more likely to present depressive symptoms than their White counterparts (Rocha et al., 2025). Thus, racialized experiences of exclusion, under-recognition, and microaggressions within educational environments must be understood not as peripheral factors but as central to explaining differential patterns of mental health among teachers.

Parenthood's impact on mental health among educators presents mixed findings, with some studies highlighting significant mental health challenges, especially among women balancing teaching and family responsibilities (Metzger and Gracia, 2023). Data from Brazilian higher education shows that parenthood is a critical factor shaping the mental health of academics, with mothers reporting higher levels of depressive symptoms than nonmothers and fathers, and with specific vulnerabilities emerging at the intersections of gender and race (Rocha et al., 2025). These findings underline the importance of extending the investigation to basic education teachers, where similar structural pressures may exacerbate the risks to mental health.

During the pandemic, these structural pressures became even more pronounced. Evidence shows that factors such as having an immunocompromising condition, teaching remotely, working extended hours, and identifying as younger, female, or a racial and ethnic minoritized educator significantly increased the risk for mental health distress among PreK–12 teachers (Smith et al., 2025). These pandemic related vulnerabilities mirror and intensify the same inequities observed in non pandemic conditions, reinforcing that gender, race, and caregiving roles operate as structural determinants of teachers' psychological well being rather than isolated sociodemographic characteristics.

3 Materials and methods

To answer our research questions, we adopted a quantitative research design. Specifically, this is a cross-sectional study conducted with an online convenience sample. Quantitative research was the most suitable approach, as it allowed for a robust statistical analysis, providing a detailed and comparative understanding of the data collected.

3.1 Ethical considerations and data collection

The project was approved by the Research Ethics Committee of the Fluminense Federal University (CAAE 52739721.0.0000.5243).

Data for this study were collected through a self administered online questionnaire. Teachers were invited to participate on a voluntary basis between March 10 and June 10, 2022. The survey was disseminated through social media, email, and messaging applications. The invitation described the purpose of the study, eligibility criteria being 18 years or older and currently working as a basic education teacher in Brazil, and assured anonymity and confidentiality. Before accessing the questionnaire, participants read an informed consent form and confirmed agreement electronically.

The questionnaire comprised two main sections: one focusing on sociodemographic characteristics and another containing the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) psychometric scale to assess depressive symptoms. Sociodemographic information included age, gender, race, state of residence, and parental status. Work-related variables covered the type of institution (public, private, community, or more than one). In addition, participants were asked whether they had ever received a mental health diagnosis from a psychiatrist or psychologist before the COVID-19 pandemic, with response options including depression, generalized anxiety, panic disorder, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, phobia, post-traumatic stress disorder, burnout, or “no diagnosis.” For the purposes of this study, these responses were collapsed into a dichotomous variable indicating self-reported prior psychiatric diagnosis. It is important to note that the instrument did not collect information on whether these diagnoses were related to COVID-19 or other life events, and we therefore interpret this measure broadly as an indicator of mental health history. It is important to note that by the time the survey was publicized, most teachers had already resumed in-person activities, despite ongoing effects of the COVID-19 pandemic. Nevertheless, teachers had already been vaccinated, as they were included among the priority groups at the beginning of Brazil's national vaccination campaign in mid-2021.

The PHQ-9 scale data was used to evaluate the depression status according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 5 (DSM-5) criteria (American Psychiatric Association, DSM-5 Task Force, 2013). The PHQ-9 is composed of nine items that evaluate major depressive symptoms as described in the DSM, while also measuring symptom severity, using a Likert scale with total scores ranging from 0 to 27 points. Each item refers to the frequency of symptoms experienced during the previous two weeks, scored from 0 (“not at all”) to 3 (“nearly every day”). According to established guidelines, PHQ-9 total scores are categorized as 0–4 minimal, 5–9 mild, 10–14 moderate, 15–19 moderately severe, and 20–27 severe depressive symptoms. The validation of the PHQ-9 was confirmed in a sample of the Brazilian population by Santos et al. (2013) showing adequate sensitivity and specificity for depression screening using a cutoff score of ≥ 9 points. Hence, in the present study, we classified the participants as having probable depression or not based on this threshold. Therefore, the results obtained should be interpreted as an estimate of the presence and severity of depressive symptoms, according to the standardized guidelines provided by this instrument.

3.2 Sample and data analysis

The original sample comprised 273 teachers working in basic education across public and/or private institutions in Brazil. Eligibility criteria for participation included being 18 years of age or older and currently working as a basic education teacher in the Brazilian educational system.

For analytical purposes, certain adjustments were made to the dataset. In the analysis of race, individuals self-identifying as *preta* and *parda* were combined into a single category referred to as “Black,” following the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) classification standards. Respondents identifying as Asian ($n = 4$), Indigenous ($n = 1$), or who selected “prefer not to say” ($n = 8$) were not included from the race-based analysis due to the very small sample sizes within those categories, which could

compromise statistical reliability. Similarly, participants who identified as *non-binary* ($n = 2$) were not included in the gender-based analyses, as the small number of respondents precluded statistical comparisons. Therefore, the initial sample of 273 basic education teachers was reduced to a final analytical sample of 258 participants. Descriptive statistics for the smaller demographic groups are nonetheless presented in Table 1 to provide a comprehensive view of the sample composition. It is important to highlight that the limited number of participants in these categories also restricts the ability to explore intersections between variables such as gender and race.

Statistical analysis was performed using non-parametric Mann–Whitney tests to compare PHQ-9 scores across key demographic variables, including gender, parenthood status, and race. These tests were chosen due to the non-normal distribution of the PHQ-9 in our sample. Rank-biserial correlation was used to evaluate the magnitude of these bivariate comparisons. In addition to group comparisons, a multiple logistic regression analysis was conducted to examine the predictive value of various factors on the probability of depression. The model included gender (male or female), race (white or black), parenthood status (not having children or having children), the absence or presence of a prior psychiatric diagnosis and age (as a continuous covariate). The assumptions of the multivariable logistic model were met. To further explore the robustness of our results, we compared our model parameters with a few reduced models. These results are found in the Supplementary material. All analyses were conducted using Sigmaplot 14.0 (SYSTAT Software, Inc.) and RStudio (R Core Team, 2024) with the ‘car’ (Fox and Weisberg, 2019), ‘effectsiz’ (Ben-Shachar et al., 2020), and ‘boot’ (Canty and Ripley, 2024; Davison and Hinkley, 1997) packages.

4 Results

To address the research questions, we first present descriptive results on depressive symptoms in the overall sample, followed by subgroup comparisons according to gender, race, parenthood, and prior psychiatric history. We then summarize the associations observed in the multivariable logistic regression model.

We assessed the overall prevalence and severity of depressive symptoms in the full sample of teachers ($n = 258$). Basic education teachers had a mean PHQ-9 score of $10.08 (\pm 7.37)$, with a median of 9 (IQR = 11). The box plot is presented in Figure 1A. Additionally, 50.4% of participants scored above the cutoff score, indicating a high proportion of individuals with probable depression among basic education teachers (Figure 1B). The distribution of PHQ-9 scores across severity categories is presented in Table 2, providing a clearer view of the overall burden of symptoms in the sample, with 28.7% of teachers reporting moderately severe or severe levels. These findings suggest that basic education teachers are at great risk for depression, both in terms of the severity of symptoms and the overall prevalence of depression within this population. Given these findings, subsequent analyses were conducted to examine in detail the factors that may influence their high vulnerability to depression.

In order to investigate the specific factors influencing the increased vulnerability of basic education teachers to depression, we first analyzed gender differences within this group. Regarding gender (Figure 2A), we observed a significant difference when comparing the

TABLE 1 Sociodemographic characteristics of the initial ($n = 273$) and final ($n = 258$) samples.

Variable	Initial sample ($n = 273$)			Final sample ($n = 258$)		
	<i>N</i> (%)	PHQ-9 Mean (SD)	PHQ-9 Median (IQR)	<i>N</i> (%)	PHQ-9 Mean (SD)	PHQ-9 Median (IQR)
Gender						
Men	61 (22.3%)	7.66 (7.05)	6 (11)	58 (22.5%)	7.76 (7.22)	6.5 (11.75)
Women	210 (76.9%)	10.51 (7.29)	9 (11)	200 (77.5%)	10.75 (7.30)	9 (11)
Non-binary	2 (0.7%)	13.00 (5.66)	13 (4)	–		
Race*						
White	164 (60.1%)	9.62 (7.30)	7.50 (11)	164 (63.6%)	9.62 (7.30)	7.50 (11)
Black	27 (9.89%)	12.15 (8.95)	12 (16.50)	27 (10.4%)	12.15 (8.95)	12 (16.5)
Parda	69 (25.3%)	10.45 (6.73)	9 (9)	67 (26%)	10.37 (6.78)	9 (8.5)
Asian	4 (1.47%)	6 (4.24)	7.50 (4.50)	–		
Indigenous	1 (0.36%)	19 (NA)	19 (NA)	–		
Prefer not to say	8 (2.93%)	4 (2.20)	4.50 (3.25)	–		
Parenthood						
Has children	161 (59%)	9.94 (7.54)	8 (11)	154 (59.7%)	10.21 (7.57)	9 (12)
No children	112 (41%)	9.83 (7.01)	8.5 (10)	104 (40.3%)	7.11 (8.50)	8.5 (10)
Age						
18–24 years	8 (2.93%)	13.62 (6.78)	11.50 (9)	8 (3.10%)	13.62 (6.78)	11.5 (9)
25–34 years	50 (18.3%)	9.48 (6.76)	8 (10.25)	43 (16.7%)	9.67 (6.75)	8 (9)
35–44 years	104 (38.1%)	10.25 (7.12)	9 (11)	100 (38.8%)	10.37 (7.23)	9 (11.5)
45–54 years	76 (27.8%)	10.28 (8.15)	8.50 (13.25)	73 (28.3%)	10.53 (8.20)	9 (14)
55–64 years	33 (12.1%)	7.82 (6.66)	6 (8)	33 (12.8%)	7.82 (6.66)	6 (8)
65 and older	2 (0.73%)	6.50 (6.36)	6.50 (4.5)	1 (0.3%)	11 (NA)	11 (NA)
Region						
North	18 (6.59%)	8.28 (5.09)	8.5 (6.75)	17 (6.59%)	8.53 (5.12)	9 (6)
Northeast	17 (6.23%)	7 (5.43)	6 (6)	15 (5.81%)	7.73 (5.34)	7 (5.5)
Central-West	40 (14.7%)	13.85 (8.18)	14.5 (13.5)	36 (14%)	14.19 (8.40)	15.5 (14.75)
Southeast	173 (63.4%)	9.36 (7.25)	8 (12)	165 (64%)	9.51 (7.32)	8 (12)
South	25 (9.16%)	10.36 (6.80)	8 (8)	25 (9.69%)	10.36 (6.80)	8 (8)
History of psychiatric disorder						
Yes	124 (45.4%)	12.58 (7.33)	11 (11)	118 (45.7%)	12.76 (7.42)	11 (11.75)
No	149 (54.6%)	7.66 (6.51)	6 (8)	140 (54.3%)	7.81 (6.54)	6 (9)

*Terminology follows the official Brazilian census and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). Race/ethnicity categories are based on a skin color continuum ranging from very fair to very dark skin. We adopt official IBGE categories in the questionnaires: *branca* (White), *preta* (Black), *parda*, *amarela* (Yellow; translated as Asian) and *indígena* (Indigenous). In Brazil, there is a common distinction between people who identify as Black (dark-skin Black people) and *parda* (light-skin Black people). In all results presented in the report, the Black category refers to both IBGE categories (*preta* and *parda*) together.

PHQ-9 scores between men (median = 6.5, IQR = 11.75) and women (median = 9, IQR = 11) in basic education ($p = 0.003$, rank-biserial $r = -0.26$, 95% CI $[-0.41, -0.10]$). The difference of nearly three points in the median PHQ-9 scores between women and men indicates a meaningful gap in symptom burden. When examining the percentage of individuals scoring above the cutoff point on the PHQ-9 scale, we found that female teachers in basic education had a higher percentage (54%) when compared to men (37.9%), indicating a greater proportion of probable depression in women (Figure 2B). This gender gap highlights how women in teaching face disproportionate emotional strain, consistent with the broader literature on gendered patterns of mental health.

With regard to parenthood, teachers in basic education who had children presented slightly higher PHQ-9 scores (median = 9, IQR = 12) compared to those without children (median = 8.5, IQR = 10) (Figure 3A), with no statistically significant difference between the groups ($p = 0.893$, rank-biserial $r = -0.01$, 95% CI $[-0.15, 0.13]$). Additionally, a similar proportion of teachers with children (50.6%) scored above the cutoff point, compared to 50% among non-parents (Figure 3B). It is important to note that the analysis considered mothers and fathers together, which may obscure specific effects associated with motherhood, especially if effects among fathers are minimal. Nevertheless, the near identical prevalence among parents and non-parents suggests that the

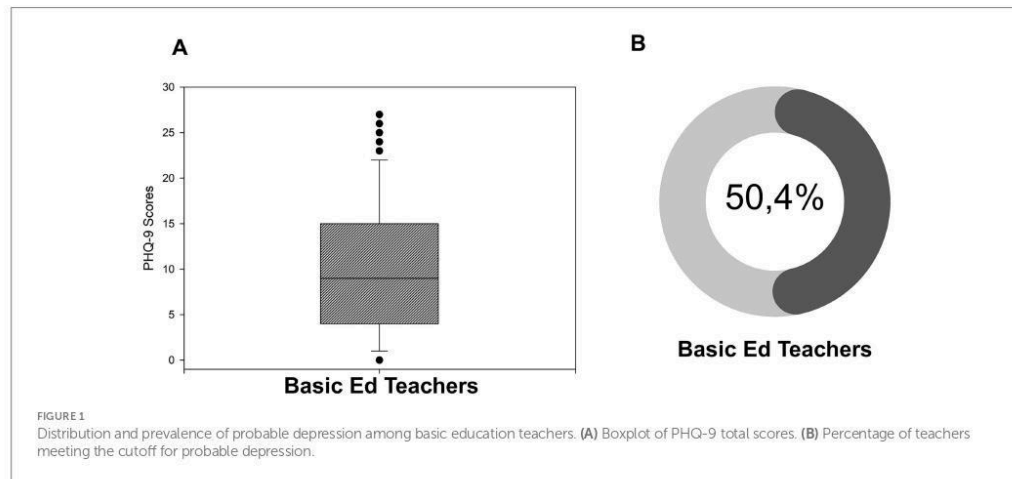


TABLE 2 Distribution of PHQ-9 depressive symptom severity among basic education teachers ($n = 258$).

PHQ-9 severity category	<i>n</i>	%
Minimal (0–4)	69	26.7
Mild (5–9)	74	28.7
Moderate (10–14)	41	15.9
Moderately severe (15–19)	35	13.6
Severe (20–27)	39	15.1

professional context itself may be a stronger determinant than parenthood status.

Considering race, Black teachers in basic education presented a higher PHQ-9 score (median = 11, IQR = 10) compared to White teachers (median = 7.5, IQR = 11), as shown in Figure 4A. Although the difference in scores suggests greater depressive symptom severity among Black teachers, the comparison did not reach statistical significance ($p = 0.115$, rank-biserial $r = -0.11$, 95% CI $[-0.25, 0.03]$). However, a larger proportion of Black teachers (59.6%) scored above the PHQ-9 cutoff, compared to 45.1% of White teachers (Figure 4B), pointing to a potential trend of increased vulnerability to depression among Black educators in basic education.

Finally, we explored the role of prior psychiatric diagnosis, which is closely linked to current mental health vulnerability. A total of 45.7% of teachers reported having received a psychiatric diagnosis from a psychologist or psychiatrist before the COVID-19 pandemic (Table 1). Teachers with a prior psychiatric diagnosis were considerably more likely to score above the PHQ 9 cutoff than those without such history. While 36.4% of teachers without a prior diagnosis met the threshold for probable depression, this proportion rose to 66.9% among those with a prior diagnosis, highlighting the strong association between mental health history and current depressive symptoms.

Taken together, these bivariate results indicate that gender and mental health history are strongly associated with probable depression,

while race shows a suggestive pattern, and parenthood does not appear to be a significant factor. To further explore the contribution of specific sociodemographic variables to the probability of depression, and considering the significant group differences observed in earlier analyses, a multiple logistic regression was conducted. This approach allows for the examination of individual predictors while controlling for possible confounding effects. The model included gender, race, age, parenthood, and previous diagnosis of a psychiatric disorder as independent variables. These variables were selected based on their theoretical relevance for determining probable depression and on the results of prior bivariate analyses, which highlighted their importance. As shown in Table 3, gender ($OR = 1.96$; $p = 0.038$) and previous mental health conditions ($OR = 3.46$; $p < 0.001$) emerged as significant predictors. Although not statistically significant ($OR = 1.62$; $p = 0.082$), an odds ratio of 1.62 suggests an increased vulnerability among Black teachers. These findings indicate that being a woman and having a prior history of psychiatric disorders are key risk factors for depression among basic education teachers, with race potentially playing a contributory role.

5 Discussion

This study aimed to evaluate the depression levels and related mental health factors in teachers in basic education in Brazil, as well as identifying which variables may predict these outcomes, considering gender, race, and parenthood. The data obtained from the PHQ-9 scale revealed that basic education teachers had a high probability of depression. Additionally, when segregated by gender, women showed higher scores for depression in basic education. Regarding parenthood, there was no significant difference between teachers with children and teachers without children. Regarding race, Black teachers showed higher median PHQ-9 scores and a greater proportion above the cutoff for probable depression compared to White teachers, although this difference was not statistically significant. Gender and previous mental disorders were significantly associated with probable depression. While our analytical focus was

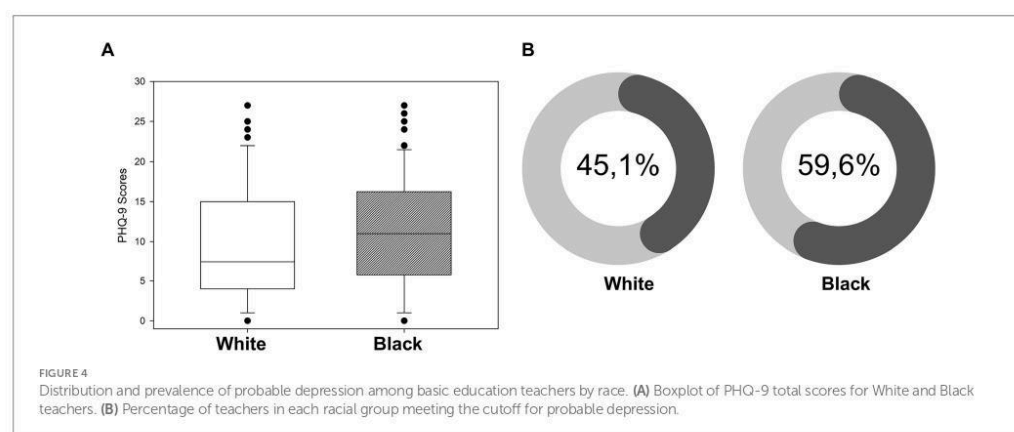
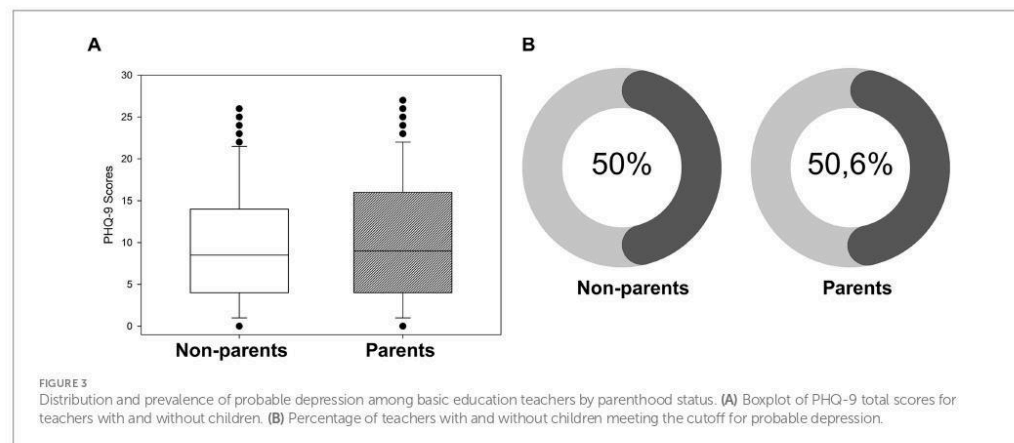
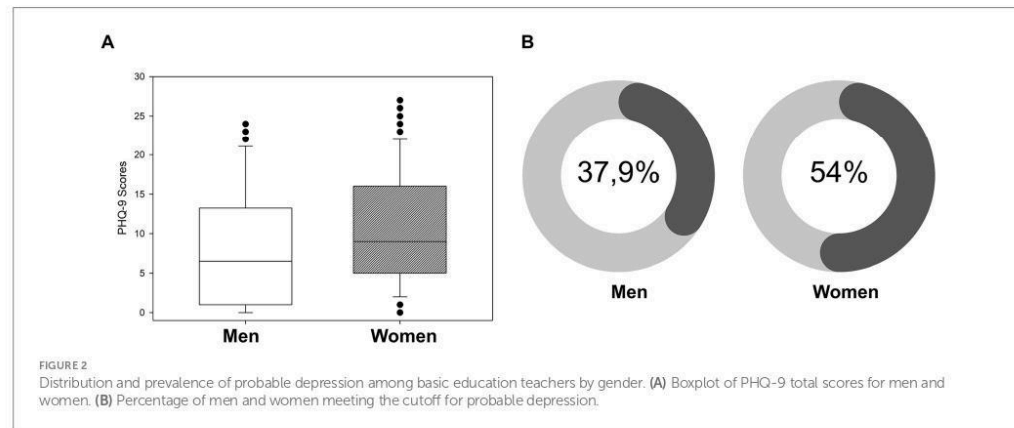


TABLE 3 Multivariable logistic regression with probable depression as dependent variable ($n = 258$).

Variable	OR	95% CI	Z-score	p-value
Parenthood				
No	Reference			
Yes	1.208	0.69, 2.13	0.66	0.510
Gender				
Men	Reference			
Women	1.957	1.05, 3.73	2.08	0.038
Race				
White	Reference			
Black	1.621	0.94, 2.81	1.75	0.082
Age	0.986	0.96, 1.02	-0.93	0.352
Previous diagnosis of mental disorder				
No	Reference			
Yes	3.463	2.05, 5.92	4.61	0.000

OR, Odds ratio; CI, confidence interval.

on individual sociodemographic factors, these variables should be interpreted as indicators of broader structural conditions rather than isolated personal characteristics. This interpretation is consistent with the job demands and resources model, which assumes that social positions and institutional arrangements shape how demands and resources are distributed across workers and, consequently, how mental health risks are patterned.

It is important to interpret the results obtained in our study in light of the timing of data collection, which occurred in 2022, shortly after the return to in-person teaching during the COVID-19 pandemic. This context was marked by residual health concerns, increased demands to address learning losses, and blurred boundaries between work and personal life following extended periods of remote teaching. Previous studies have shown that these conditions significantly impacted teachers' lives (Pereira et al., 2023; Troitinho et al., 2021). Therefore, while the high prevalence of depressive symptoms observed here likely reflects long-standing structural vulnerabilities in the teaching profession, it may also have been intensified by the cumulative burden of the pandemic period. This contextual factor does not diminish the structural nature of the problem; rather, it illustrates how chronic vulnerabilities in the teaching profession were further exposed and aggravated by the pandemic.

Our study offers an in-depth look at the mental health of basic education teachers in Brazil, contributing to the growing body of research that seeks to understand the psychological burdens faced by educators. By focusing on a national sample, our findings provide a broader and more representative picture of the current situation, which is essential given that much of the existing literature is based on studies conducted in individual schools, municipalities, or specific regions. This national scope allows us to capture a more comprehensive view of the challenges faced by teachers across different contexts. The results are concerning: 50.4% of basic education teachers in our sample scored above the PHQ-9 cutoff, indicating a high prevalence of probable depression. Local studies have reported similar figures. For instance, Ruas et al. (2022), in a study conducted with public

school teachers in Montes Claros, in southeastern Brazil, found that 52.6% of teachers were diagnosed with depression, highlighting the concerning nature of this finding. Baldaçara et al. (2015), in a study involving 109 public school teachers in Palmas, in the north of Brazil, found that 49.5% of teachers exhibited Common Mental Disorder (CMD). da Rocha and de Souza (2013), in a study conducted in 31 public schools in Pelotas, in the south of Brazil, with 575 secondary education teachers, estimated the prevalence of CMD to be 43.8%. Batista et al. (2013) found that more than half of the medical leave cases (51%) among teachers in João Pessoa, in the northeast of Brazil, were due to diagnoses related to depression, preventing them from working for some time. Filippsen and Marin (2020) observed that 80.6% of the teachers in their sample were classified as having depression indicators ranging from normal to mild, 6.5% were moderate, and 12.9% had severe to extremely severe depression. These alarming rates, consistently found across different regions of Brazil, suggest that traditional frameworks used to explain occupational stress, such as the job demands-resources model (Demerouti et al., 2001; Bakker and Demerouti, 2017), may need to be critically expanded when applied to teaching. While this model predicts increased vulnerability to adverse mental health outcomes under conditions of high demand and low support, the high prevalence of probable depression observed in our study points to a context where resource depletion is not episodic but chronic, creating a situation closer to structural exhaustion than situational imbalance. In interpreting this scenario, the burnout theory (Maslach and Leiter, 1997; Schaufeli, 2017) offers important insights. Burnout describes a psychological condition characterized by emotional exhaustion, depersonalization, and a diminished sense of personal accomplishment, typically emerging from prolonged exposure to occupational stressors. In the environment of Brazilian basic education, marked by political instability, lack of social recognition, and institutional precariousness, the conditions that favor burnout are not only present but deeply entrenched. Rather than representing an occasional risk, the chronic exposure to emotionally draining work may lead to accelerated trajectories of burnout among teachers, eroding psychological resilience over time. Although burnout and depression are distinct constructs, growing evidence highlights the strong interconnections between them. Several studies have demonstrated that burnout is significantly associated with higher levels of depression and anxiety (Koutsimani et al., 2019). In Italy, teachers with higher levels of burnout reported higher levels of depression (Capone et al., 2019). A meta-regression analysis by Meier and Kim (2022) reinforces the connection between burnout and depression, while also highlighting that this relationship can be shaped by variables such as age, gender, and length of professional experience. These findings are critical for interpreting our results: the pervasive depressive symptoms identified in our sample may reflect not only isolated psychological distress but the cumulative effects of long-standing occupational burnout processes that, left unaddressed, transition into clinical depression. This interpretation is supported by longitudinal studies that indicate a directional relationship from burnout to depression. Hakanen et al. (2008), in a panel study of Finnish workers, demonstrated that burnout predicted later depression, rather than the reverse. Similar patterns were observed by Hakanen and Schaufeli (2012) in a three-wave study, where increases in burnout were found to precede increases in depressive symptoms. Additionally, Shin et al. (2013), in a longitudinal study with teachers

in Korea, reported that initial levels of burnout significantly predicted depressive symptoms 18 months later. Collectively, these findings strengthen the hypothesis that chronic exposure to burnout processes may constitute a key pathway leading to the development of clinical depression among teachers. Thus, while our study measured depressive symptoms, the contextual reading provided by burnout theory helps to illuminate the underlying occupational dynamics that may be propelling teachers from chronic emotional exhaustion to more severe psychological conditions. Taken together, these findings provide empirical support for the idea, central to both burnout and job demands and resources frameworks, that prolonged exposure to high demands in the absence of adequate resources can gradually transform occupational strain into clinically relevant depressive symptoms. The findings suggest that interventions aimed at improving teacher mental health must not only target individual symptoms but also address the organizational structures that sustain continuous emotional depletion and systemic disregard for educators' well-being.

Troitinho et al. (2021) stated that one of the significant causes impacting the mental health of basic education teachers in Brazil was emergency remote learning. Pereira et al.'s (2023) findings indicated that the shift to remote learning significantly affected teachers' personal and professional lives. Emergency remote teaching collapsed traditional boundaries between work and home, intensifying work-family conflicts and overburdening teachers with demands for which few institutional resources were available. From the perspective of the job demands-resources model (Demerouti et al., 2001; Bakker and Demerouti, 2017), this shift dramatically increased demands, such as technological adaptation, content redesign, and constant availability, without providing corresponding resources like training, time flexibility, or psychosocial support. The abrupt overlap of professional and personal roles, particularly for women teachers, also resonates with the work-family conflict theory (Greenhaus and Beutell, 1985), highlighting how unresolved conflicts between spheres of life produce cumulative stress and contribute to psychological exhaustion. Research during the pandemic has reinforced these patterns. The pandemic context can be understood not as introducing new pressures but as accelerating the accumulation of chronic occupational stressors, pushing many teachers beyond their adaptive thresholds. The collapse of minimal protective buffers previously maintained by teachers illustrates how precarious their working conditions already were prior to COVID-19. Thus, the pandemic did not merely create new challenges; it exposed and amplified the longstanding structural frailties of the educational system in supporting teacher well-being.

As seen in the present study, female teachers in basic education had the highest percentage (54%) of individuals scoring above the cutoff point on the PHQ-9. According to the women reported being diagnosed with depression approximately 2.8 times more frequently than men. When comparing the years 2013 and 2019, the proportion of individuals reporting a depression diagnosis slightly increased more among women (35%) than among men (31%). A study by Maggioni et al. (2008) showed that women are more affected by depression, accounting for 71.11% of occurrences. Indeed, Faria (2024) corroborates these findings in his study with 308 teachers from the state school system in Londrina, in the south of Brazil, where 36.5% of women and 25% of men were classified as depressed (mild, moderate, or severe depression). Mendes Rodrigues et al. (2019) found that of the 163 teachers interviewed in a public institution in

Teresina, in the northeast of Brazil, 74.8% presented some level of depression, with 79.8% of women and 64.8% of men being affected. A similar result was observed by Tostes et al. (2018), whose study with teachers from a public school in Paraná, in the south of Brazil, showed higher prevalence of depression at any level in women (67.86%) compared to men (54.32%). Barreto and Hissa (2020) conducted a study with secondary school teachers in Fortaleza, in the northeast of Brazil, and found that 67% of teachers with mental health issues were women, presenting varying degrees of depression severity. Segat and Diefenthaler (2013) also found in their study with basic school teachers that the onset of depressive illnesses and the use of antidepressant medications is more common among women. International data reinforce this pattern: in a study with Peruvian teachers, Estrada-Aaroz et al. (2023) found that women were more likely than men to present moderate and high levels of depression (30.9% vs. 5.3%, respectively). Similarly, in Poland, depressive behaviors were significantly more frequent among women teachers (26%) than among men (14%) (Domagalska et al., 2021). Collectively, all these studies align with our research findings that indicate that women were almost twice affected by depression in comparison to men ($OR = 1.95$, $p = 0.038$). The persistent and robust gender differences observed in depression prevalence among teachers invite a theoretical reflection on how work and family responsibilities intersect with occupational demands to disproportionately affect women. Work-family conflict theory (Greenhaus and Beutell, 1985) offers a crucial perspective here, suggesting that women often face overlapping and competing pressures in both the domestic and professional spheres, leading to chronic emotional strain. In the teaching profession, which is historically feminized and emotionally demanding, these dynamics become even more acute. Female teachers are not only expected to deliver professional excellence under precarious working conditions, but are also often burdened with primary caregiving roles outside the school environment, creating a continuous cycle of unresolved demands and limited recovery opportunities. Moreover, the layering of these demands over time can erode psychological resilience, making women teachers particularly vulnerable to the onset of depression. The accumulation of workplace pressures, emotional labor, societal expectations, and family responsibilities contributes to an environment where the risk of mental health deterioration is persistently higher for women. Our findings, therefore, not only confirm the epidemiological patterns documented in the literature but also reinforce the argument that structural gender inequalities are central to understanding mental health disparities in education. In this sense, the gender pattern observed in our data offers a concrete example of how work family conflict and job demands and resources perspectives operate within a feminized profession marked by chronic emotional demands and limited institutional support. Addressing these disparities requires moving beyond individual-level interventions and tackling the systemic factors that reproduce unequal distributions of emotional burden between men and women within and beyond the teaching profession.

Regarding race, although not reaching the statistical significance level, we observe that the odds of scoring above the cutoff point for probable depression is 62% higher for Black teachers ($OR = 1.62$, $p = 0.082$), consistent with Gouveia Damasceno and Zanillo (2018), who state that depression is one of the most significant effects of racial discrimination on the mental health of the black population. Martins

and Santos (2023) further support this, emphasizing that, in addition to socioeconomic factors and poor-quality healthcare services, depression is closely related to suicidal behavior, hereditary factors, and the lack of effective public policies, all of which threaten the lives of Black individuals. Although the difference did not reach conventional levels of statistical significance, this result must be interpreted with caution given the unequal group sizes: only 96 participants self-identified as Black, compared to 164 who identified as White. The relatively small number of Black participants likely limited the statistical power of the analysis, and it is plausible that with larger subsamples the difference would reach significance. But, regardless of the fact that the difference did not reach conventional levels of statistical significance, the magnitude of the association suggests that racialized experiences within the teaching profession contribute meaningfully to the vulnerability to depression among Black educators. From the perspective of critical race theory (Delgado and Stefancic, 2017), these findings can be interpreted not as isolated phenomena but as outcomes embedded in structural and institutional dynamics that perpetuate racial inequalities. In educational contexts, racism may manifest through mechanisms such as professional marginalization, limited access to leadership positions, daily microaggressions, and lack of institutional support, all of which cumulatively erode psychological well-being. Repeated exposures to racial discrimination function as chronic stressors, accumulating over time and undermining mental health resilience. The convergence of occupational stressors and racial discrimination thus creates a particularly hazardous environment for Black teachers, amplifying the risks of emotional suffering and depression. Recognizing the role of racism as a determinant of health is crucial for developing mental health policies and institutional practices that move beyond generic interventions and explicitly address the intersectional vulnerabilities faced by Black educators.

Previous psychiatric disorder was also a significant predictor of probable depression ($OR = 3.46$; $p < 0.001$). In our study, 45.7% of basic education teachers reported having a prior psychiatric diagnosis, a proportion notably higher than that found in other studies, such as Baptista et al. (2023), who reported 30.09%. According to Brasil (2019) and Brasil. Ministério da Saúde (2021), having a previous mental health condition such as anxiety, bipolar disorder, a family history of depression, or past depressive episodes is considered an important risk factor for developing depression. This strong association between prior psychiatric diagnosis and current depressive symptoms is consistent with international literature. For instance, Cho et al. (2022) demonstrated in a large case-control study that psychiatric disorders and sleep-related conditions substantially increase the odds of developing major depressive disorder, reinforcing the interpretation that pre-existing vulnerabilities play a decisive role in shaping current mental health outcomes. This finding underscores the importance of secondary prevention strategies and of providing sustained institutional support for educators with pre-existing vulnerabilities. The elevated proportion observed in our sample may reflect the cumulative effects of chronic work-related stress or increased awareness and willingness to report mental health issues among educators. Further investigation is needed to better understand how these prior conditions interact with professional demands and contribute to the increased vulnerability of basic education teachers. From a theoretical standpoint, this result is compatible with models that conceptualize burnout and depression as partially overlapping

trajectories, in which pre-existing vulnerabilities amplify the impact of demanding and poorly resourced work environments.

Parenthood was not significantly associated with depression ($OR = 1.2$, $p = 0.510$). It is important to note that the variable parenthood included both fathers and mothers together. The heterogeneity of experiences of parenthood between men and women may be the factor underlying this lack of significant difference. Indeed, previous studies suggest that mental health fluctuations associated with parenthood tend to be more pronounced among women than men (Metzger and Gracia, 2023). Previous studies in higher education in Brazil have shown that parenthood interacts strongly with gender and race, with mothers (and especially Black mothers) reporting higher prevalence of depressive symptoms than fathers or women without children (Rocha et al., 2025). This suggests that future research should examine parental roles with greater granularity to capture these intersectional dynamics. The absence of an overall association in our data does not contradict work family conflict theory, but rather indicates that more detailed measures of caregiving intensity and role overload are needed to fully test its expectations in the context of basic education.

5.1 From evidence to action: addressing teacher mental health in Brazil

The results of this study reveal that nearly half of basic education teachers in Brazil experience depressive symptoms at a level consistent with probable depression, with women and those with a prior psychiatric diagnosis disproportionately affected, and Black teachers showing a concerning trend of increased vulnerability. These patterns collectively mirror the mechanisms described by burnout and job demands and resources theories, in which structural imbalances between demands and available resources generate unequal distributions of psychological strain among different social groups. Our findings highlight structural inequalities within the educational system and demand urgent and context-specific policy responses. Unfortunately, investment in education in Brazil, particularly in basic education, remains below the level required to provide teachers with adequate support. Mental health policies are often absent from educational planning, leaving the burden of coping to individuals who already operate in precarious conditions. To move from evidence to action, resources must be reallocated and expanded to prioritize teacher well-being as a foundation for educational quality.

Based on our findings, we recommend the following actions:

- 1 Institutionalized mental health monitoring: Establish periodic use of validated screening tools within schools, accompanied by referral pathways to public health services (SUS). Given that teachers with a prior psychiatric history showed the highest vulnerability, specific protocols should be developed to ensure follow-up for educators with known risk factors.
- 2 Targeted support for women and Black educators: Gender and race emerged as critical axes of inequality. Policies should explicitly address these intersectional vulnerabilities, for example by offering mentorship and peer support programs for Black women teachers, strengthening access to career development opportunities, and creating safe channels to report discrimination and harassment in the workplace.

- 3 Expansion of psychosocial services within education systems: Schools should be integrated into broader community health networks, ensuring that psychological and psychiatric support is accessible and confidential. Dedicated school-based professionals, such as psychologists and social workers, are essential for reducing stigma and facilitating timely intervention.
- 4 Workload reorganization: Our data indicate that the burden of depression is not explained by parenthood alone but reflects the cumulative strain of professional demands. Reducing excessive non-teaching administrative tasks, ensuring reasonable teaching loads, and providing paid time for professional development are critical strategies to prevent the progression from chronic stress to clinical depression.
- 5 Training of school leaders in mental health-responsive management: Principals and administrators play a decisive role in shaping school culture. Leadership development programs should include training on recognizing signs of mental health distress, implementing inclusive practices, and fostering environments that value teacher well-being.
- 6 Policy integration and funding priorities: Teacher mental health should be incorporated into national and state-level education plans, with dedicated funding streams. Investments in this area should not be seen as ancillary but as central to improving educational outcomes, reducing absenteeism, and retaining qualified educators.

We acknowledge the severe financial and staffing constraints faced by Brazilian schools, particularly in basic education. Resources for education remain insufficient, and mental health support is rarely prioritized in institutional planning. We are aware that implementing the recommendations outlined here would require a significant reorientation of priorities in a system already underfunded and overburdened. Still, presenting these pathways is essential: even if they are difficult to achieve under current conditions, they highlight the direction that policies and institutional practices must move toward if teacher well-being is to be taken seriously.

By situating teacher mental health as a structural challenge rather than an individual failing, these recommendations emphasize that the sustainability of Brazilian education depends on policies that protect and support those who sustain it.

5.2 Limitations and future directions

This study has some limitations that should be considered when interpreting the results. First, the reliance on self-reported data introduces potential biases, such as underreporting or overreporting of depressive symptoms. While the PHQ-9 is a validated and widely used screening tool, the subjective nature of self-assessment may affect the accuracy of depression probability estimates. Second, the sample size of male participants was relatively small compared to female participants, which may limit the generalizability of gender comparisons and the broader applicability of the findings. Third, although the study captured key sociodemographic variables, it did not account for other potential factors that could influence teachers' mental health, such as specific work environment conditions, levels

of institutional support, or individual coping strategies. The questionnaire did not collect additional work-related variables such as years of teaching experience, workload, specific job duties, or detailed working conditions. These factors are highly relevant for understanding teacher mental health but were not part of the instrument used in this study and are acknowledged as limitations. Future studies with larger samples are warranted and should address these and other relevant variables, including type of school, region of the country, and the nature of the institution (public or private), among others. Fourth, although the study was disseminated nationwide in Brazil, it cannot be considered a national-level epidemiological study due to the limited number of responses collected, which undermines the representativeness required for research of this nature. In addition, the study relied on broad sociodemographic variables that do not fully capture the structural mechanisms discussed in the theoretical framework. This conceptual limitation restricts the extent to which the findings can speak to the complexity of the systemic processes shaping teachers' mental health.

Despite these limitations, the study provides valuable insights into the mental health challenges faced by basic education teachers in Brazil. The results highlight the urgent need to prioritize mental health care for teachers, emphasizing both the prevention and appropriate treatment of depressive symptoms. Future research must continue to unravel the complex pathways linking professional structures, social inequalities, and mental health outcomes, ensuring that interventions are not only evidence-based but also socially just.

6 Conclusion

This study sheds light on a pervasive and deeply rooted mental health challenge within the educational sector. Nearly half of Brazilian basic education teachers scored at or above the PHQ-9 cutoff indicating probable depression. Women and teachers with a prior psychiatric diagnosis had higher odds of probable depression, a racial disparity likely affecting Black teachers approached significance, and parenthood was not significant. These results suggest that depression risk in this workforce is shaped by structural conditions in schooling rather than individual factors alone. Institutions and policymakers should reduce chronic job demands, provide confidential psychological support with clear referral pathways, and implement equity oriented measures that address gender and race based vulnerabilities. It is essential to foster an organizational culture that values and supports teacher well-being, moving beyond the rhetoric of resilience to implement structures and resources that sustain mental health throughout educators' careers.

Future research should adopt longitudinal and mixed method designs, include richer workplace metrics and intersectional analyses, and test multi level interventions that combine organizational change with improved access to care.

Data availability statement

The raw data supporting the conclusions of this article will be made available by the authors, without undue reservation.

Ethics statement

The studies involving humans were approved by Research Ethics Committee—Fluminense Federal University. The studies were conducted in accordance with the local legislation and institutional requirements. The participants provided their written informed consent to participate in this study.

Author contributions

KS: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – review & editing, Writing – original draft. AM: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – review & editing, Writing – original draft. SR: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – review & editing. RM: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – review & editing. MN: Conceptualization, Investigation, Methodology, Writing – review & editing. MP: Conceptualization, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Writing – review & editing. LO: Conceptualization, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Supervision, Writing – review & editing. Writing – original draft. FS: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Project administration, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing.

Funding

The author(s) declared that financial support was received for this work and/or its publication. This work was supported by the federal and state Brazilian Funding Agencies Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) -CAPES/PRINT Finance code 001, and Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

References

- Agyapong, B., Obuobi-Donkor, G., Burbach, L., and Wei, Y. (2022). Stress, burnout, anxiety and depression among teachers: a scoping review. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 19:10706. doi: 10.3390/ijerph191710706
- American Psychiatric Association, DSM-5 Task Force (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5™, 5th Edn. Washington: American Psychiatric Publishing, Inc.
- Bakker, A. B., and Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: taking stock and looking forward. *J. Occup. Health Psychol.* 22, 273–285. doi: 10.1037/ocp0000056
- Baldaçara, L., Silva, Á. F., Díaz Castro, J. G., and Santos, G. C. A. (2015). Common psychiatric symptoms among public school teachers in Palmas, Tocantins, Brazil: an observational cross-sectional study. *São Paulo Med J* 133, 435–438. doi: 10.1590/1516-3180.2014.8242810
- Baptista, C. J., Martins, A. M., and Escalada, P. M. F. (2023). Fatores associados a altos escores de saúde mental de professores universitários durante a pandemia de COVID-19. *Saude Pesqui.* 16, 1–12. doi: 10.17765/2176-9206.2023v16n1e11419
- Barreto, R. M. M., and Hissa, D. L. A. (2020). Depressão e o impacto na prática docente em professores do ensino médio da rede estadual de ensino em Fortaleza (CE). Repositório UFC. Available online at: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/54651>
- Batista, J. B. V., Carlotto, M. S., and Moreira, A. M. (2013). Depressão como causa de afastamento do trabalho: Um estudo com professores do ensino fundamental. *Psico* 44, 257–262.
- Ben-Shachar, M., Lüdtke, D., and Makowski, D. (2020). Effectsize: estimation of effect size indices and standardized parameters. *J. Open Source Softw.* 5:2815. doi: 10.21105/joss.02815
- Borges, J. L. J., Santos, M. E. S., and Pinto, N. R. (2022). Gênero e saúde no trabalho docente em serviço social. *Rev. Remesc* 1, 91–94. doi: 10.24281/Imostracientifica2022.191-94
- Borges, K., Araújo, C. H. S., and Oliveira, A. S. (2022). Intensificação do trabalho docente. *Rev. Triangulo* 15. doi: 10.18554/rt.v15i1.6165
- Brasil 2019 Depressão: Causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e prevenção Available online at: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/depressao>
- Brasil. Ministério da Saúde. (2021). Atendimento pré-hospitalar em saúde mental: noções das urgências e emergências em saúde mental. Available online at: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atendimento_pre_hospitalar_saude_mental_nocoes_urgencias.pdf
- Brun, L. G., and Monteiro, J. K. (2020). Preditores de depressão em docentes do ensino privado. *Aletheia* 53. doi: 10.29327/226091.53.2-5
- Canty, A., and Ripley, B. (2024). Boot: bootstrap R (S-plus) functions. R package version 1.3-31.
- Capone, V., Joshnloo, M., and Park, M. S.-A. (2019). Burnout, depression, efficacy beliefs, and work-related variables among school teachers. *Int. J. Educ. Res.* 95, 97–108. doi: 10.1016/j.ijer.2019.02.001

Acknowledgments

We would like to express our sincere gratitude to all the participants who responded to the survey for their valuable contributions.

Conflict of interest

The author(s) declared that this work was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Generative AI statement

The author(s) declared that Generative AI was not used in the creation of this manuscript.

Any alternative text (alt text) provided alongside figures in this article has been generated by Frontiers with the support of artificial intelligence and reasonable efforts have been made to ensure accuracy, including review by the authors wherever possible. If you identify any issues, please contact us.

Publisher's note

All claims expressed in this article are solely those of the authors and do not necessarily represent those of their affiliated organizations, or those of the publisher, the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article, or claim that may be made by its manufacturer, is not guaranteed or endorsed by the publisher.

Supplementary material

The Supplementary material for this article can be found online at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2025.1669000/full#supplementary-material>

- Cho, Y., Mishi, I., Akaki, T., Akimoto, T., and Fujikawa, K. (2022). Diseases prevalent before major depressive disorder diagnosis: an exploratory nested case-control study using health insurance-based claims data. *BMJ Open* 12:e048233. doi: 10.1136/bmjopen-2020-048233
- da Rocha, L. M., and de Souza, L. D. (2013). Voice handicap index associated with common mental disorders in elementary school teachers. *J. Voice* 27, 595–602. doi: 10.1016/j.jvoice.2012.10.001
- Davison, A. C., and Hinkley, D. V. (1997). *Bootstrap Methods and their Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Delgado, R., and Stefancic, J. (2017). *Critical Race Theory*. 3rd Edn. New York: NYU Press.
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., and Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *J. Appl. Psychol.* 86, 499–512. doi: 10.1037/0021-9010.86.3.499
- Domagalska, J., Rusin, M., Razzaghi, M., and Nowak, P. (2021). Personality type D, level of perceived stress, insomnia, and depression among high school teachers in Poland. *Front. Psychol.* 12:626945. doi: 10.3389/fpsyg.2021.626945
- Estrada-Aroz, E. G., Gallegos-Ramos, N. A., and Velásquez-Giersch, L. (2023). Mental health of basic education teachers during the return to face-to-face education. *Rev. Cubana Med. Mil.* 52, 575–582.
- Faria (2024). Depressão em professores da rede estadual de ensino de Londrina/PR: Caracterização e fatores associados. Repositório UEL. <https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14813> (Accessed October 24, 2024).
- Filippen, O., and Marin, A. (2020). Clima escolar e indicadores de estresse, ansiedade e depressão em professores do ensino técnico médio privado. *Psicol. Teor. Prat.* 22, 230–246. doi: 10.5935/1980-6906/psicologia.v22n3p247-262
- Fox, J., and Weisberg, S. (2019). *An R Companion to Applied Regression*. 3rd Edn. Thousand Oaks CA: Sage.
- Ghasemi, F. (2025). Teachers' mental health challenges and contributing risk factors: a systematic narrative review based on the socio ecological model. *Psychol. Sch.* 62, 2111–2135. doi: 10.1002/pits.23455
- Gouveia Damasceno, M., and Zanello, V. M. L. (2018). Saúde mental e racismo contra negros: produção bibliográfica brasileira dos últimos quinze anos. *Psicol. Cienc. Prof.* 38, 450–464. doi: 10.1590/1982-37030003262017
- Greenhaus, J. H., and Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. *Acad. Manag. Rev.* 10:76. doi: 10.2307/258214
- Hakanen, J. J., and Schaufeli, W. B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. *J. Affect. Disord.* 141, 415–424. doi: 10.1016/j.jad.2012.02.043
- Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B., and Ahola, K. (2008). The job demands-resources model: a three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. *Work Stress* 22, 224–241. doi: 10.1080/02678370802379432
- He, L., Huang, L., Huang, Y., Li, H., Zhang, Z., Li, J., et al. (2025). Prevalence and influencing factors of anxiety, depression, and burnout among teachers in China: a cross sectional study. *Front. Psychol.* 16:1567553. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1567553
- Instituto Cactus 2023 Panorama de Saúde Mental: Ferramenta dinâmica de pesquisa e monitoramento contínuo da saúde mental dos brasileiros (1º semestre) Available online at: <https://panoramasaudemental.org/> (Accessed September 28, 2024).
- Koutsimani, P., Montgomery, A., and Georganta, K. (2019). The relationship between burnout, depression, and anxiety: a systematic review and meta-analysis. *Front. Psychol.* 10:284. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00284
- Madigan, D. J., Kim, L. E., Glandorf, H. L., and Kavanagh, O. (2023). Teacher burnout and physical health: a systematic review. *Int. J. Educ. Res.* 119:102173. doi: 10.1016/j.ijer.2023.102173
- Maggioni, D. C., Sclaro, L. L., Mella Junior, S. E., and Mella, E. A. C. (2008). Levantamento do consumo de antidepressivos em um município do oeste de Santa Catarina. *Inic Cient Cesumar* 10, 55–62.
- Martins, J. R., and Santos, M. A. C. (2023). A depressão nas mulheres negras brasileiras: Um estudo acerca do racismo estrutural e seu impacto psíquico. *ACIS* 11, 37–60.
- Maslach, C., and Leiter, M. P. (1997). *The Truth about Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to do About It*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Meier, S. T., and Kim, S. (2022). Meta-regression analyses of relationships between burnout and depression with sampling and measurement methodological moderators. *J. Occup. Health Psychol.* 27, 195–206. doi: 10.1037/ocp0000273
- Mendes Rodrigues, L. T., Lago, E. C., Almeida, C. A. P. L., Ribeiro, I. P., and Mesquita, G. V. (2019). Estresse e depressão em docentes de uma instituição pública de ensino. *Enferm. Glob.* 19, 209–242. doi: 10.6018/eglobal.19.1.383201
- Metzger, S., and Gracia, P. (2023). Gender differences in mental health following the transition into parenthood: longitudinal evidence from the UK. *Adv. Life Course Res.* 56:100550. doi: 10.1016/j.alcr.2023.100550
- Moreno-Jimenez, B., Garrosa-Hernandez, E., Gálvez, M., González, J. L., and Benevides-Pereira, A. M. T. (2002). A avaliação do burnout em professores: Comparação de instrumentos CBP-R e MBI-ED. *Psicol. Estud.* 7, 11–19. doi: 10.1590/s1413-73722002000100004
- Morris, R. W., Kim, L. E., Milton, A., and Glozier, N. (2025). The growing effect of job demands on teacher mental health: results from a longitudinal national household panel survey. *BMC Public Health* 25:1810. doi: 10.1186/s12889-025-22372-5
- Pereira, M. D., Assis, L., and Feldens, D. G. (2023). Saúde mental da professora e os efeitos da pandemia em sua docência na educação básica: Um olhar a partir da perspectiva de gênero. *Educ. (UFES)*. doi: 10.5902/1984644470057
- Possa, J. D. B., and Krause, M. (2023). Saúde mental dos professores na contemporaneidade: Impactos educacionais. *Rev. Saberes Sabores Educ.* 10, 153–168.
- R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing.
- Ribeiro, V., Teixeira, R., Silva, A., Hahns-Júnior, H., Cardoso, B., Santos, N., et al. (2023). Alteração do estado emocional de professores da educação básica brasileira. *Rev. Psicopedagogia* 40, 28–37. doi: 10.51207/2179-4057.20230003
- Rocha, S., Stanislauski, F., Nudelman, M. F., Lana, R., Martins, R. M., Fernandes, J., et al. (2025). The impact of parenthood on mental health within the academic community: highlighting vulnerabilities and identifying high-risk groups. *Humanit. Soc. Sci. Commun.* 12. doi: 10.1057/s41599-025-05178-z
- Ruas, C. F. A., Oliveira, W. N., Silva, L. L. F., Soares, R. S. M. V. M., and Soares, W. D. (2022). Prevalência de depressão e ansiedade em professores da rede pública na era COVID-19. *Cad. UniFOA* 17, 165–171. doi: 10.47385/cadunifoa.v17.n49.3691
- Sabagh, Z., Hall, N. C., and Saroyan, A. (2018). Antecedents, correlates and consequences of faculty burnout. *Educ. Res.* 60, 131–156. doi: 10.1080/00131881.2018.1461573
- Santos, I. S., Tavares, B. F., Munhoz, T. N., Almeida, L. S. P., Silva, N. T. B., Tams, B. D., et al. (2013). Sensibilidade e especificidade do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) entre adultos da população geral. *Cad. Saude Publica* 29, 1533–1543. doi: 10.1590/0102-311X00144612
- Schaufeli, W. B. (2017). Applying the job demands-resources model: a 'how to' guide to measuring and tackling work engagement and burnout. *Organ. Dyn.* 46, 120–132. doi: 10.1016/j.orgdyn.2017.04.008
- Segat, E., and Diefenthaler, H. (2013). Uso de medicamentos antidepressivos por professores de escolas de diferentes redes de ensino em um município do norte do Rio Grande do Sul. *Perspectiva* 137, 45–54.
- Shin, H., Noh, H., Jang, Y., Park, Y. M., and Lee, S. M. (2013). A longitudinal examination of the relationship between teacher burnout and depression. *J. Employ. Counsell.* 50, 124–137. doi: 10.1002/j.2161-1920.2013.00031.x
- Silva, N. R., Bolsoni-Silva, A. T., and Loureiro, S. R. (2018). Burnout e depressão em professores do ensino fundamental: Um estudo correlacional. *Rev. Bras. Educ.* 23. doi: 10.1590/s1413-24782018230048
- Smith, A. J., Johnson, A. L., Miyazaki, Y., Weber, M. C., Wright, H., Griffin, B. J., et al. (2025). Risk for mental health distress among PreK 12 teachers during the COVID 19 pandemic. *Psychol. Sch.* 62, 1622–1633. doi: 10.1002/pits.23421
- Tostes, M., Souza, G., de Cavalcanti Albuquerque, M. J. S., and Petterle, R. (2018). Mental distress of public school teachers. *Saude Debate*. doi: 10.1590/0103-1104201811607
- Troithino, M. d. C. R., Silva, I. B., Sousa, M. M., Santos, A. D. d. S., and Maximino, C. (2021). Ansiedade, afeto negativo e estresse de docentes em atividade remota durante a pandemia da COVID-19. *Trab. Educ. Saude* 19. doi: 10.1590/1981-7746-sol00331
- UNESCO (2024). *Global Report on Teachers: Addressing Teacher Shortages and Transforming the Profession*. Paris: UNESCO eBooks.
- Vedovato, T. G., and Monteiro, M. I. (2008). Perfil sociodemográfico e condições de saúde e trabalho dos professores de nove escolas estaduais paulistas. *Rev. Esc. Enferm. USP* 42, 291–297. doi: 10.1590/s0080-62342008000200012
- Watts, J., and Robertson, N. (2011). Burnout in university teaching staff: a systematic literature review. *Educ. Res.* 53, 33–50. doi: 10.1080/00131881.2011.552235
- WHO (2022). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. Geneva: WHO.
- Zagni, B., Pellegrino, G., Ianes, D., and Scrimin, S. (2025). Unraveling teacher stress: a cumulative model of risks and protective factors in Italian schools. *Int. J. Educ. Res.* 131:102603. doi: 10.1016/j.ijer.2025.102603

6 DISCUSSÃO

Nosso estudo evidencia a complexidade que envolve a saúde mental dos docentes, ressaltando as diferenças marcantes entre aqueles que atuam no ensino básico e no ensino superior. Os achados deste estudo evidenciam um quadro consistente e preocupante de adoecimento mental entre docentes no Brasil, com maior gravidade entre aqueles que atuam no nível básico de ensino. De forma convergente, os resultados apontam elevadas prevalências de sintomas depressivos, sintomas de TEPT, maior percepção de solidão e níveis mais baixos de otimismo nesse grupo, quando comparado aos docentes do ensino superior. Esse padrão reforça evidências nacionais e internacionais de que a docência, especialmente na educação básica, configura-se como uma ocupação de alto risco psicossocial, marcada por intensificação do trabalho, precarização das condições laborais e elevada demanda emocional (Maslach; Leiter, 2016; Souza *et al.*, 2021).

No que se refere à depressão, os dados revelaram que quase metade dos docentes da educação básica apresentou pontuação acima do ponto de corte da escala PHQ-9, indicando alta probabilidade de diagnóstico de depressão. A consistência desse achado com estudos conduzidos em diferentes regiões do país sugere que o adoecimento mental docente não se trata de um fenômeno localizado ou episódico, mas de um problema estrutural da educação básica brasileira (Silva; Dalagasperina, 2020; Batista *et al.*, 2022). Essa interpretação dialoga diretamente com a análise de Tostes (2018), que compreende o adoecimento psíquico docente como resultado de um processo histórico de intensificação e precarização do trabalho educativo, marcado pela ampliação das exigências, pela perda de autonomia profissional e pela fragilização do reconhecimento social da docência. A magnitude das prevalências observadas aponta, assim, para um cenário de esgotamento psicológico crônico, associado à intensificação das demandas emocionais, à precarização das condições de trabalho e à ausência de suporte institucional contínuo (Maslach; Schaufeli; Leiter, 2001).

A análise dos marcadores sociais da vulnerabilidade aprofundou a compreensão desse cenário ao evidenciar que o risco de depressão não se distribui de maneira homogênea entre os docentes da educação básica. Considerando as dimensões de gênero, evidencia-se que o adoecimento mental entre docentes da educação básica se distribui de forma desigual, afetando de maneira mais intensa as mulheres. As docentes apresentaram maior gravidade dos sintomas depressivos e maior probabilidade de diagnóstico quando comparadas aos docentes homens, achado consistente com evidências nacionais e internacionais sobre desigualdades de gênero na saúde mental docente (Araujo; Karasek, 2008; Gomes *et al.*, 2021). Esse padrão

pode ser compreendido a partir da perspectiva do conflito trabalho–família, segundo a qual a sobreposição entre demandas profissionais e responsabilidades domésticas recai de forma desproporcional sobre as mulheres, especialmente em uma profissão historicamente feminilizada e caracterizada por elevado trabalho emocional (Greenhaus; Beutell, 1985; Hirata, 2018). Além disso, a inserção das mulheres no mercado de trabalho não foi acompanhada, em termos estruturais, por uma redistribuição equitativa das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, resultando frequentemente em jornadas duplas ou triplas. Esse acúmulo contínuo de atribuições tem sido associado a sentimentos persistentes de impotência, frustração e exaustão emocional, com repercussões diretas sobre a saúde mental e o processo de adoecimento psíquico (Spíndola, 2000; Spíndola; Santos, 2003). Evidências empíricas reforçam essa interpretação, como demonstrado por Silva, Oliveira e Honorato (2023), que identificaram maior incidência de sintomas depressivos entre mulheres docentes (61,9%) em comparação aos homens (45,2%), a partir da aplicação do SRQ-20. Esses achados indicam que o gênero opera como um eixo estruturante de vulnerabilidade no trabalho docente, amplificando os efeitos dos estressores ocupacionais e reduzindo as possibilidades de recuperação psíquica, sobretudo em contextos marcados por precarização do trabalho, intensificação das demandas e fragilidade do suporte institucional. Assim, compreender o adoecimento mental docente exige reconhecer que as desigualdades de gênero não constituem fatores individuais, mas expressões de relações sociais e organizacionais que produzem riscos diferenciados à saúde mental.

Em relação à raça, embora as diferenças nas pontuações médias de depressão não tenham alcançado significância estatística, a maior proporção de docentes negros acima do ponto de corte da PHQ-9 e a tendência observada nas análises multivariadas apontam para um padrão consistente de vulnerabilidade racializada. Considerando o racismo estrutural como referencial teórico, tais processos podem ser interpretados como decorrentes da exposição contínua a desigualdades sociais e à discriminação institucional, com efeitos cumulativos sobre o acesso a recursos de proteção psicossocial (Almeida, 2019; Williams; Lawrence; Davis, 2019). No contexto educacional, essas experiências podem se manifestar por meio de microagressões, invisibilização profissional e sobrecarga emocional, contribuindo para o agravamento do sofrimento psíquico entre docentes negros, e, segundo Sue *et al.* (2007), microagressões são “indignidades verbais, comportamentais ou ambientais breves e comuns, intencionais ou não” e constituem mecanismos sutis de discriminação racial que afetam a saúde mental. Observa-se um distanciamento expressivo entre pessoas brancas e negras no que se refere ao adoecimento mental, sendo que a análise interseccional entre gênero e raça

revela maior suscetibilidade entre mulheres negras, as quais se encontram mais frequentemente posicionadas em contextos de vulnerabilidade social, tornando-se alvo preferencial do estresse ocupacional e do adoecimento mental (Sousa; Araújo, 2024).

O histórico prévio de transtornos psiquiátricos emergiu como um dos mais fortes preditores de depressão entre docentes da educação básica, indicando que o contexto de trabalho pode atuar como um fator de manutenção ou agravamento de sofrimentos psíquicos preexistentes. Esse achado dialoga com modelos de vulnerabilidade–estresse, segundo os quais exposições ocupacionais adversas podem desencadear recaídas ou intensificação de quadros prévios, especialmente na ausência de suporte institucional adequado (Ingram; Luxton, 2005, 2005; Cuijpers *et al.*, 2014). Tal evidência reforça a importância de políticas de saúde mental que considerem trajetórias anteriores de adoecimento, e não apenas intervenções reativas ao sofrimento atual.

Os resultados relacionados ao TEPT evidenciaram prevalências relevantes entre docentes, com maior gravidade na educação básica. A pandemia de COVID-19 configurou-se como um evento de estresse prolongado, marcado por isolamento social, rupturas abruptas de rotinas, insegurança econômica e exposição contínua a incertezas, condições amplamente reconhecidas como fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas pós-traumáticos (Bridgland *et al.*, 2021; Janiri *et al.*, 2021). No contexto brasileiro, esses efeitos foram agravados por desigualdades sociais históricas, instabilidade política e fragilidades institucionais (The Lancet, 2020). Entre docentes da educação básica, soma-se a esse cenário a exposição recorrente à violência no ambiente escolar, incluindo agressões verbais, intimidações e ameaças, reconhecida como importante fator de risco para TEPT e outros transtornos mentais (Facci, 2019; Lima *et al.*, 2020).

A maior percepção de solidão entre docentes da educação básica reforça a relevância das dimensões relacionais e institucionais na compreensão do sofrimento psíquico docente. A ausência de apoio organizacional, aliada à responsabilização individual dos professores pelo desempenho educacional, favorece sentimentos de isolamento e desamparo (Martinez; Silva; Costa, 2021). A literatura aponta que a solidão percebida está fortemente associada a sintomas depressivos e ansiosos, atuando como fator mediador e amplificador do adoecimento mental em contextos de alta demanda emocional (Hawkey; Cacioppo, 2010; Einav *et al.*, 2024).

Nesse conjunto de resultados, o otimismo emerge como um elemento central para compreender as diferenças observadas entre docentes da educação básica e do ensino superior. Evidências indicam que o otimismo está positivamente associado à autoeficácia docente, à

resiliência e ao uso de estratégias adaptativas de enfrentamento (Scheier; Carver, 1985; Neves, 2017). Os níveis mais elevados de otimismo observados entre docentes do ensino superior podem refletir condições de trabalho relativamente mais favoráveis, como maior autonomia, reconhecimento institucional e estabilidade profissional (Toledo; Campos, 2023). Em contrapartida, os baixos níveis de otimismo identificados entre docentes da educação básica parecem associar-se a sentimentos de desesperança e impotência, potencializando o impacto de estressores ocupacionais e ampliando a vulnerabilidade ao adoecimento mental (Fabella; Paz-Aler, 2023).

De forma integrada, os achados sugerem que o adoecimento mental entre docentes da educação básica resulta da combinação de múltiplos fatores de risco - estruturais, institucionais e psicossociais - que se acumulam ao longo do tempo. A Organização Mundial da Saúde (2022) apresentou um panorama da situação global da saúde mental que identifica lacunas nas respostas de saúde pública e propõe recomendações para a transformação de políticas sistemas e práticas o relatório enfatiza a necessidade de abordagens que ultrapassem intervenções centradas exclusivamente no indivíduo incorporando os determinantes sociais da saúde e enfrentando desigualdades estruturais como aquelas relacionadas a gênero, raça e condições de vida.

Nossos achados reforçam a necessidade de que políticas públicas de saúde mental voltadas aos docentes sejam estruturadas de forma contínua e sensível às desigualdades que atravessam a profissão, incorporando recortes de gênero e raça em seus textos e diretrizes, de modo a respeitar as especificidades das ações direcionadas a esses grupos. Embora o Brasil disponha de programas gerais de saúde mental, como o Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece uma estrutura abrangente de cuidado por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088/2011 e composta por dispositivos como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS), observa-se que poucas iniciativas consideram de forma explícita as particularidades da profissão docente, especialmente no que se refere às desigualdades de gênero e raça.

É importante destacar, contudo, que algumas experiências locais têm avançado nesse sentido no contexto brasileiro. Em Fortaleza (CE), destacam-se iniciativas desenvolvidas pela Academia do Professor Darcy Ribeiro (APROF), como o Grupo de Apoio à Saúde Mental dos Professores (GASP), o Plantão Psicológico Docente e as ações de Psicomotricidade Relacional, que oferecem suporte psicológico e emocional aos docentes, articulando-se à RAPS e buscando promover o bem-estar e o enfrentamento dos desafios inerentes à profissão. De forma semelhante, no Distrito Federal, o Programa de Saúde Mental no Trabalho (Prosm)

oferece acolhimento psicológico aos servidores da educação por meio de ações como o Papsi, voltado ao atendimento psicológico individual, e o Prodeq, focado na prevenção da dependência química, também integrados aos serviços da RAPS. Além disso, a Bahia disponibiliza manuais digitais e promove formações para professores sobre saúde mental, visando capacitar os educadores para lidar com questões emocionais no ambiente escolar. No âmbito federal, A Lei nº 13.935/2019 estabelece a obrigatoriedade da atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, enquanto a Lei nº 14.819/2024 institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Ambas as normativas convergem ao reconhecer a comunidade escolar como público de atenção, contemplando estudantes, docentes, gestores e demais profissionais da educação, com foco na promoção da saúde mental e no fortalecimento das relações institucionais.

Apesar dos avanços no campo legislativo, a efetivação das políticas públicas voltadas à saúde mental dos docentes ainda enfrenta desafios significativos. A escassez de recursos financeiros e humanos configura-se como um dos principais entraves, limitando a contratação de profissionais qualificados, a oferta de serviços adequados e a implementação da infraestrutura necessária. Diante desse cenário, os achados sobre a saúde mental docente evidenciam a urgência de ações concretas, destacando o potencial de políticas públicas territorializadas e articuladas à rede de atenção psicossocial para a promoção do bem-estar desses profissionais. Contudo, tais experiências também revelam a necessidade de ampliação, fortalecimento e institucionalização de iniciativas semelhantes em âmbito nacional. A consolidação de políticas que considerem as especificidades do trabalho docente e os marcadores sociais de vulnerabilidade mostra-se fundamental para o enfrentamento mais equitativo e efetivo do adoecimento mental entre professores, reconhecendo a saúde mental docente como um elemento central para a qualidade da educação.

7 CONCLUSÕES

A presente tese teve como foco avaliar a saúde mental de docentes do ensino básico em uma perspectiva comparativa com a do ensino superior no Brasil, considerando a prevalência de sintomas depressivos e de TEPT, bem como os níveis de otimismo e solidão. Os resultados obtidos permitem delinear um panorama abrangente da saúde mental docente, expondo um cenário preocupante, de maior vulnerabilidade, revelando as desigualdades que atravessam as diferentes experiências vivenciadas por docentes das instituições de ensino brasileiras.

Embora o adoecimento mental docente manifeste-se de forma mais intensa no ensino básico, o problema também existe no ensino superior, ainda que com características específicas em cada nível de ensino, revelando que o sofrimento psíquico permanece como uma questão central para a sustentabilidade do sistema educacional, mesmo após o período mais crítico da pandemia. Em ambos os contextos, é possível extrair que o sofrimento mental não pode ser compreendido como resultado de fragilidades individuais, mas como expressão de modelos organizacionais que negligenciam o bem-estar dos docentes. Observou-se maior vulnerabilidade entre docentes da educação básica, o que reforça a necessidade de intervenções direcionadas que considerem as especificidades das diferentes etapas de ensino e as condições concretas de trabalho a que esses profissionais estão submetidos.

No que se refere à prevalência de sintomas depressivos entre docentes do ensino básico, os resultados evidenciam a influência de marcadores sociodemográficos, especialmente gênero e raça, na distribuição do sofrimento psíquico, reforçando a presença de desigualdades estruturais na experiência docente. A parentalidade, embora considerada nas análises, não apresentou associação estatisticamente significativa com os desfechos investigados, sugerindo a necessidade de estudos que explorem possíveis efeitos mediadores ou contextuais.

Adicionalmente, a análise dos sintomas de TEPT, bem como dos níveis de solidão e otimismo entre docentes do ensino básico e superior, aponta para a relevância de dimensões psicossociais na compreensão da saúde mental docente, indicando que o sofrimento não se expressa apenas por sintomas psicopatológicos, mas também por recursos subjetivos e relacionais que modulam a vivência e o enfrentamento das adversidades do trabalho.

Investir na promoção do bem-estar psicológico dos professores não apenas contribui para a mitigação de transtornos mentais, como também fortalece o compromisso ético e social da educação, ao reconhecer que a qualidade do ensino está intrinsecamente ligada à saúde e à valorização de seus profissionais. Nesse sentido, recomenda-se a realização de novos estudos que aprofundem a compreensão dos fatores associados à saúde mental docente, bem como o desenvolvimento de estratégias e políticas públicas voltadas à promoção de ambientes educacionais mais saudáveis, equitativos e sustentáveis para os profissionais da educação.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, G. S. C. de *et al.* Exploração e sofrimento mental de professores: um estudo na rede estadual de ensino do Paraná. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 16, n. 3, p. 1287-1300, set. 2018. DOI: 10.1590/1981-7746-sol00145. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00145>. Acesso em: 18 jan. 2026.
- ALMEIDA, L. A.; ALVES, R. B.; MORAES, T. D.; BIANCO, M. F. A prioridade da saúde mental e trabalho na atenção básica. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, [S. l.], v. 13, p. 01-26, 2023. DOI: 10.5433/2236-6407.2022.v13.46348. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/eip/article/view/46348>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- ALMEIDA, S. L. **Racismo estrutural**. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 264 p. Disponível em: https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/bitstream/192/10389/1/Racismo_estrutural_%28Feminismos_-_Silvio_Luiz_de_Almeida.pdf. Acesso em: 12 nov. 2025.
- ALVES, L. A. S.; MARTINS, A. C. S.; MOURA, A. A. Desafios y aprendizajes con la enseñanza remota de los docentes de educación básica. **Revista Iberoamericana de Educación**, [S. l.], v. 86, n. 1, p. 61-78, 2021. DOI: 10.35362/rie8614373. Disponível em: <https://doi.org/10.35362/rie8614373>. Acesso em: 18 jan. 2026.
- AMAZONAS. **Lei nº 6.383, de 2 de agosto de 2023**. Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/am/lei-ordinaria-n-6383-2023-amazonas-dispoe-sobre-a-atencao-a-saude-ocupacional-dos-profissionais-de-educacao-da-rede-estadual-de-ensino-no-ambito-do-estado-do-amazonas>. Acesso em: 18 jan. 2026.
- AUGUSTO, E. A.; SILVA, F. A. C.; AIELO, A. C. O fardo oculto: a saúde mental dos docentes em lapsos de stress. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 7, p. 2552-2565, 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i7.20385. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/20385>. Acesso em: 17 nov. 2025.
- BALDAÇARA, L.; SILVA, A. F.; CASTRO, J. G. D.; SANTOS, G. C. A. Common psychiatric symptoms among public school teachers in Palmas, Tocantins, Brazil: an observational cross-sectional study. **São Paulo Medical Journal**, v. 133, n. 5, p. 435-438, 2015. DOI: 10.1590/1516-3180.2014.8242810. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2014.8242810>. Acesso em: 18 jan. 2026.
- BARBOSA, M. M.; SANTOS, A. B. O. dos; ZANONI, D. A.; BERTO, D. F. DESAFIO DOS PROFESSORES E SAÚDE MENTAL: UM TRABALHO SIGNIFICATIVO. In: SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIP, 15., 2024, Marília, SP. **Anais do XV Simpósio de Ciências Aplicadas da FAIP**. Marília, SP: FAIP, 2024. 665 p. ISSN 2525-8028. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1skAeoNjMmZtbqeZV6RQ8yYEfbGux44fk>. Acesso em: 18 jan. 2026.
- BARRETO, R. M. M.; HISSA, D. L. Depressão e o impacto na prática docente em professores do ensino médio da rede estadual de ensino em Fortaleza (CE). **Revista Educação em Debate**, Fortaleza (CE), v. 42, n. 82, p. 87-104, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/54651>. Acesso em: 20 fev. 2023.

BARROS, A. O.; BARROS, A. L. O.; MATTOS, R. M. p. R. des; SANTANA, B. R. O.; BARRETO, I. D. de C.; PIMENTEL, D. Afastamento do trabalho por depressão em docentes da rede pública. **Debates em Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 6-17, 2019. DOI: 10.25118/2763-9037.2019.v9.62. Disponível em:

<https://revistardp.org.br/revista/article/view/62>. Acesso em: 6 fev. 2025.

BLANCO, M. B.; CANTO-DE-SOUZA, A. L. M. Ansiedade, memória e o transtorno de estresse pós-traumático. **Revista CES Psicologia**, v. 11, n. 2, p. 53-65, 2018. DOI: 10.21615/cesp.11.2.5.

BORGES, J. L.; SANTOS, M. E. S.; PINTO, N. R. Gênero e saúde no trabalho docente em serviço social. In: MOSTRA CIENTÍFICA EM ANTROPOLOGIA E SAÚDE: DIÁLOGOS EM GÊNERO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS, 1., 2022. p. 91-94. DOI: 10.24281/Imostracientifica2022.1.91-9.

BORGES, K.; ARAÚJO, C. H. S.; OLIVEIRA, A. S. Intensificação do trabalho docente. **Revista Triângulo**, 2022. DOI: 10.18554/rt.v15i1.6165.

BORRALHO, L.; CANDEIAS, A. A.; DE JESUS, S. N.; VISEU, J. Healthy school, healthy teachers: mediating effect of optimism. **Frontiers in Psychology**, v. 16, 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1506161.

BOTTEGA, C. G.; PEDROSO, R. Saúde mental dos professores da rede de Ensino Público e gestão: uma relação possível (?). **Revista Ciências do Trabalho**, n. 13, 2019. Disponível em: <https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/view/185>. Acesso em: 25 jan. 2025.

BRASIL, C. C. p.; BATISTA, M. H.; MELO, A. K. da S.; IBIAPIA, F. L. p.; BRILHANTE, A. V. M.; DA SILVA, R. M. O contexto da docência e sua influência no sofrimento psíquico de professoras do ensino fundamental. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 180-188, 2016. DOI: 10.5020/18061230.2016.p180. Disponível em: <https://ojs.unifor.br/RBPS/article/view/5174>. Acesso em: 8 fev. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.216, de 2001**. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Oficial da União, Brasília, 6 abr. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.935, de 2019**. Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Diário Oficial da União, Brasília, 12 dez. 2019. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13935-11-dezembro-2019-789559-publicacaooriginal-159616-pl.html>. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.819, de 2024**. Institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Diário Oficial da União, Brasília, 17 jan. 2024. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-14819-16-janeiro-2024-795256-publicacaooriginal-170863-pl.html>. Acesso em: 1 maio 2025.

BRASIL. **Lei nº 306, de 3 de agosto de 2023**. Estabelece diretrizes para a promoção da saúde mental nas escolas estaduais. Diário Oficial do Estado do Amazonas, Manaus, 3 ago. 2023. Disponível em: https://legisla.imprensaoficial.am.gov.br/diario_am/12/2023/8/9949. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.679, de 20 de setembro de 2002**. Institui a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 2002. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/cerest>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRITO, J. *et al.* Saúde, gênero e reconhecimento no trabalho das professoras: convergências e diferenças no Brasil e na França. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 24, n. 2, p. 589–605, 2014. DOI: 10.1590/S0103-73312014000200014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312014000200014>. Acesso em: 19 jul. 2023.

BRUN, L. G.; MONTEIRO, J. K. Preditores de depressão em docentes do ensino privado. **Aletheia**, v. 53, n. 2, p. 63-76, 2020. Disponível em: <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/aletheia/article/view/6277/3931>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CACIOPPO, J. T.; CACIOPPO, S. Social relationships and health: The toxic effects of perceived social isolation. **Social and Personality Psychology Compass**, v. 8, n. 2, p. 58–72, 2014. DOI: 10.1111/spc3.12087. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/spc3.12087>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CACIOPPO, S.; GRIPPO, A. J.; LONDON, S.; GOOSSENS, L.; CACIOPPO, J. T. Loneliness: Clinical import and interventions. **Perspectives on Psychological Science**, v. 10, n. 2, p. 238–249, 2015. DOI: 10.1177/1745691615570616. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1745691615570616>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CAMACHO, K. G.; MOORE, D. C. B. C.; JUNQUEIRA-MARINHO, M. F.; GOMES JÚNIOR, S. C.; REIS, A. T.; ABRAMOV, D. M. Lockdown during the COVID-19 pandemic: lessons from a polarized scenario in Brazil. **Frontiers in Psychology**, v. 15, 1310594, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1310594>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CAMPOS, M. F.; VIEGAS, M. F. Saúde mental no trabalho docente: um estudo sobre autonomia, intensificação e sobrecarga. **Cadernos de Pesquisa**, v. 28, n. 2, p. 417, 2021. DOI: 10.18764/2178-2229.v28n2.202132. Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/13270>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CARVALHO, A. M. B. DE; SQUARISI, K. M. V. Saúde mental docente na pandemia e pós-pandemia da COVID-19: análise de políticas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. **Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal**, v. 11, n. 1, p. 1–16, 2024. Disponível em: <https://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/1806>. Acesso em: 18 jan. 2026.

CARVER, C. S.; SCHEIER, M. Optimism. In: LOPEZ, S. J.; SNYDER, C. R. (org.). **Positive psychological assessment: a handbook of models and measures**. Washington: American

Psychological Association, 2003. p. 75–89. Disponível em:
<https://doi.org/10.1037/10612-005>. Acesso em: 19 jan. 2026.

CECÍLIO, S.; NASCIMENTO, G. M. p. Trabalho docente antes e durante a pandemia da SARS-CoV-2: os impactos na vida dos professores. **Revista Triângulo**, v. 16, n. 2, 2023. Disponível em:
<https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/revistatriangulo/article/view/6983>. Acesso em: 18 mar. 2025.

CIPRIANO, J. A. *et al.* Docência e ansiedade: a ampliação do pse como medida preventiva na saúde mental do professor. In: CONEDU, 6. **Anais VI CONEDU**. Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em:
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/TRABALHO_EV127_MD4_SA18_ID1248_15082019134137.pdf. Acesso em: 20 mar. 2025.

COSTA, G. M. *et al.* Saúde mental em período emergencial remoto: uma revisão sistemática sobre a prevalência de transtornos de ansiedade e depressão entre profissionais da educação. **Contribuciones a las ciencias sociales**, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 7020–7037, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.1-424. Disponível em:
<https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4681>. Acesso em: 1 fev. 2025.

CUNHA, S. D. M.; MATOS SOBRINHO, J. D. A.; SILVEIRA, A. R.; SAMPAIO, C. A. Vivências, condições de trabalho e processo saúde-doença: retratos da realidade docente. **Educação em Revista**, v. 40, p. e36820, 2024. DOI: 10.1590/0102-469836820. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-469836820>. Acesso em: 18 jan. 2026.

D'ANGELIS, J. L. D.; FONSECA, G. C.; SCHETTINO, S.; BARBOSA, R. E. C. Trabalho docente e Covid-19: revisão da produção científica sobre repercussões da pandemia na saúde mental de docentes do ensino superior. **APRENDER - Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação**, n. 31, p. 269–282, 2024. DOI: 10.22481/aprender.i31.14574. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/aprender/article/view/16324>. Acesso em: 24 nov. 2025.

DAROSCI, M.; CABRAL, S. B. A. A residência multiprofissional como política de formação e atuação: o que representa essa dualidade? In: SEMINÁRIO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL, 3., 2019, Florianópolis. **Anais do III Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Política Social**. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/202548>. Acesso em: 20 mar. 2025.

DEJOURS, C. **A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho**. 5. ed. São Paulo: Cortez Oboré, 1992.

DEMARTINI, S. S.; AMARAL-ROSA, M.; CERUTTI, E. A solidão docente na Educação Básica on-line: percepções de professores acerca dos desafios e superações. **Nuances: Estudos sobre Educação**, Presidente Prudente, v. 34, n. 00, p. e023023, 2023. DOI: 10.32930/nuances.v34i00.9532. Disponível em:
<https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/9532>. Acesso em: 23 nov. 2025.

DIEHL, L.; MARIN, A. H. Adoecimento mental em professores brasileiros: revisão sistemática da literatura. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, Londrina, v. 7, n. 2, p.

64-85, dez. 2016. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-64072016000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 jan. 2025.

EINAV, M.; CONFINO, D.; GEVA, N. *et al.* Teachers' burnout: the role of social support, gratitude, hope, entitlement and loneliness. **International Journal of Applied Positive Psychology**, v. 9, p. 827–849, 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.1007/s41042-024-00154-5>. Acesso em: 19 jan. 2026.

FABELLA, F. E.; PAZ-ALER, R. A. D. Optimism as a mitigator of burnout: the relationship between optimism and burnout among selected teachers. **International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science**, 2023. Disponível em:

<https://doi.org/10.56726/irjmets33431>. Acesso em: 19 jan. 2026.

FAN, C.; FU, p.; LI, X.; LI, M.; ZHU, M. **Trauma exposure and the PTSD symptoms of college teachers during the peak of the COVID-19 outbreak**. *Stress and Health*, v. 37, n. 5, p. 914-927, 2021. DOI: 10.1002/smi.3049. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8250066/pdf/SMI-37-914.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.

FERREIRA MELO, L. Políticas públicas educacionais, rotina escolar e adoecimento psíquico docente. **Educação Básica Revista**, v. 5, n. 1, p. 3–14, 2020. Disponível em:

<https://www.educacaobasicarevista.com.br/index.php/ebr/article/view/28>. Acesso em: 9 abr. 2025.

FERREIRA-COSTA, R.; PEDRO-SILVA, N. Níveis de ansiedade e depressão entre professores do Ensino Infantil e Fundamental. **Pro-Posições**, v. 30, p. e20160143, 2019.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pp/a/prLXmmdXG3hdQWTSBgm6JZD/#>. Acesso em: 1 abr. 2024.

FIOCRUZ. **Boletim extraordinário do Observatório Covid-19**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. Disponível em:

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_extraordinario_2021-marco-16-red-red-red.pdf. Acesso em: 19 jan. 2026.

FORTALEZA. **Academia do Professor Darcy Ribeiro**. Disponível em:

<https://sites.google.com/educacao.fortaleza.ce.gov.br/aprofsmefortaleza/ceapro>. Acesso em: 13 maio 2025.

FREITAS, R. F. *et al.* Prevalência e fatores associados aos sintomas de depressão, ansiedade e estresse em professores universitários durante a pandemia da COVID-19. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 70, n. 4, p. 283-292, 2021. DOI: 10.1590/0047-2085000000348.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000348>. Acesso em: 18 jan. 2026.

GASPARINI, S. M.; BARRETO, S. M.; ASSUNÇÃO, A. Á. Prevalência de transtornos mentais comuns em professores da rede municipal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. **Cadernos De Saúde Pública**, v. 22, n. 12, p. 2679-2691, 2006. DOI:

10.1590/S0102-311X2006001200017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2006001200017>. Acesso em: 18 jan. 2026.

GODOY, A. Carreira docente: um gigante desafio. **SUL21**, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://sul21.com.br/opiniaio/2025/01/carreira-docente-um-gigante-desafio-por-ana-boff-de-godoy/>. Acesso em: 25 jan. 2025.

GOIÁS. **Lei nº 4925, de 2024**. Estabelece políticas estaduais de saúde mental para a educação básica em Goiás. Diário Oficial do Estado de Goiás, Goiânia, 2024.

GOLDSTEIN, E.; TOPITZES, J.; BROWN, R. L.; JUSSEL, A. B. Mental health among university employees during the COVID-19 pandemic. **Psychological Trauma**, v. 15, n. 3, p. 536–545, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/tra0001332>. Acesso em: 19 jan. 2026.

GOMES, A. p. R.; QUINTÃO, S. R. Burnout, satisfação com a vida, depressão e carga horária em professores. **Análise Psicológica**, v. 29, n. 2, p. 335-344, 2011. DOI: 10.14417/ap.56. Disponível em: <https://doi.org/10.14417/ap.56>. Acesso em: 18 jan. 2026.

GONZÁLEZ-GARCÍA, H.; FUENTES, S.; RENOBELL, V. A cross-sectional study of teacher's motivational profiles during COVID-19 lockdown: relationship with teaching satisfaction, loneliness and affects. **BMC Psychology**, v. 13, n. 1, p. 948, 2025. DOI: 10.1186/s40359-025-03261-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03261-3>. Acesso em: 18 jan. 2026.

GOUVEIA DAMASCENO, M.; ZANELLO, V. M. L. Saúde mental e racismo contra negros: produção bibliográfica brasileira dos últimos quinze anos. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 38, n. 3, p. 450-464, jul./set. 2018. DOI: 10.1590/1982-37030003262017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/gPSLSxDcHDhDccZgpk3GNVG/?lang=pt>. Acesso em: 18 jan. 2026. Guerreiro *et al.*, N. p. *et al.* Perfil sociodemográfico, condições e cargas de trabalho de professores da rede estadual de ensino de um município da região sul do Brasil. Trabalho, Educação e Saúde, v. 14, p. 197-217, nov. 2016. DOI: 10.1590/1981-7746-sol00027. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00027>. Acesso em: 26 jan. 2025.

HAWKLEY, L. C.; CACIOPPO, J. T. Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. **Annals of Behavioral Medicine**, v. 40, n. 2, p. 218-27, 2010. DOI: 10.1007/s12160-010-9210-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12160-010-9210-8>. Acesso em: 18 jan. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional de Saúde 2019: Percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9160-pesquisa-nacional-desauade.html?edicao=29270&t=resultados>. Acesso em: 28 set. 2024.

JANIRI, D.; CARFÌ, A.; KOTZALIDIS, G. D. *et al.* Posttraumatic stress disorder in patients after severe COVID-19 infection. **JAMA Psychiatry**, v. 78, n. 5, p. 567–569, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.0109>. Acesso em: 19 jan. 2026.

KESSLER, R. C.; MCGONAGLE, K. A.; ZHAO, S. *et al.* Lifetime prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. **Archives of General Psychiatry**, v. 51, n. 1, p. 8–19, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1994.03950010008002>. Acesso em: 19 jan. 2026.

KOGA, G. K. C. *et al.* Fatores associados a piores níveis na escala de Burnout em professores da educação básica. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 23, n. 3, p. 268-275, jul. 2015. DOI: 10.1590/1414-462X201500030121. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201500030121>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LANA, R. M. *et al.* Vulnerability and protective factors for PTSD in the academic community during the pandemic. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 39, n. 1, 2026. DOI: 10.1186/s41155-025-00372-z. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s41155-025-00372-z>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LEÃO, F. L. p. **Relações saúde, trabalho e resiliência do docente-tutor na educação a distância**. 2014. 120 p. Dissertação (Mestrado) – Programa de PósGraduação Stricto Sensu Interdisciplinar em Desenvolvimento Humano: Formação, Políticas e Práticas Sociais, 2014. Disponível em: <http://mpemdh.unitau.br/wp-content/uploads/2011/dissertacoes/maranhao/Flor-de-Liz-Pereira-Leao.pdf>. Acesso em: 15 out. 2020. Leigh-Hunt, N. *et al.* An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. *Public Health*, v. 152, p. 157-171, 2017. DOI: 10.1016/j.puhe.2017.07.035. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.07.035>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LI, S. *et al.* The prevalence and correlates of burnout among Chinese preschool teachers. **BMC Public Health**, v. 20, p. 160, 2020. DOI: 10.1186/s12889-020-8287-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-8287-7>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LIMA, B. R. M. de; OLIVEIRA, V. da S. C. C. de; SANTOS, E. C.; SOUSA, R. M. de; VALIM, M. D. F. Fatores associados aos transtornos mentais comuns em professores do ensino fundamental. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 8, p. e15374, 2024.

LIMA, F. G.; VECCHI, L. M.; PALOSKI, L. H. Saúde mental de docentes universitários: uma revisão sistemática da literatura. **Linhas Críticas**, [S. l.], v. 30, p. e50850, 2024. DOI: 10.26512/lc30202450850. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/50850>. Acesso em: 17 nov. 2025.

LIMA, I. B. de; ALVES, D.; FUREGATO, A. R. F. Indicadores de saúde mental para a Rede de Atenção Psicossocial brasileira: uma proposta. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 30, p. e3599, 2022. DOI: 10.1590/1518-8345.5618.3599. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5618.3599>. Acesso em: 18 jan. 2026.

LUZ, D. A. M.; KAEFER, C. O. L. A saúde mental dos professores da rede pública que atuam no ensino médio: uma contribuição do fazer da psicologia. **Cadernos Brasileiros de Saúde Mental/Brazilian Journal of Mental Health**, [S. l.], v. 14, n. 41, p. 19-37, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/71246>. Acesso em: 28 jan. 2025.

MAGALHÃES, T. A. *et al.* Preditores dos sintomas de estresse em uma amostra de professores da educação básica do ensino público brasileiro. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [S. l.], v. 15, n. 2, 2023. DOI:

10.36692/V15n2-40. Disponível em:
<https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/1301>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MARINHO, M. p.; ALBUQUERQUE, A. R. de. Depressão em professores do Ensino Fundamental: fatores de adoecimento e estratégias de enfrentamento. **Revista Profissão Docente**, [S. l.], v. 24, n. 49, p. 1-18, 2024. DOI: 10.31496/rpd.v24i49.1623. Disponível em: <https://revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/1623>. Acesso em: 4 fev. 2025.

MARTINEZ, F. W. M.; SILVA, A. M.; COSTA, A. C. O. Precariedades e incertezas: trabalho docente do professor iniciante em tempos de covid-19. **Linhas Críticas**, v. 27, e39036, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/lc27202139036>. Acesso em: 19 jan. 2026.

MARTINS, J. R.; SANTOS, M. A. C. A depressão nas mulheres negras brasileiras: Um estudo acerca do racismo estrutural e seu impacto psíquico. **ACiS**, v. 11, n. 1, p. 37-60, 2023. Disponível em: <https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/ACIS/article/view/2735/1743>. Acesso em: 18 jan. 2026.

MASLACH, C.; LEITER, M. p. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. **World Psychiatry**, v. 15, p. 103–111, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/wps.20311>. Acesso em: 19 jan. 2026.

MASLACH, C.; SCHAUFELI, W. B.; LEITER, M. p. Job burnout. **Annual Review of Psychology**, v. 52, p. 397–422, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>. Acesso em: 19 jan. 2026.

MATO GROSSO. **Lei nº 11.867, de 2022**. Institui a Política Estadual de Saúde Mental nas Escolas em Mato Grosso. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, 2022.

METZGER, S.; GRACIA, p. Gender differences in mental health following the transition into parenthood: Longitudinal evidence from the UK. **Advances in Life Course Research**, p. 100550, 2023. DOI: 10.1016/j.alcr.2023.100550. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2023.100550>. Acesso em: 18 jan. 2026.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). **Programa Saúde na Escola garante direito à saúde e reduz desigualdades nos territórios brasileiros**. Brasília, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/fevereiro/programa-saude-na-escola-garante-direito-a-saude-e-reduz-desigualdades-nos-territorios-brasileiros>. Acesso em: 12 maio 2025.

MONDRAGON, N. I.; FERNANDEZ, I. L.; OZAMIZ-ETXEBARRIA, N.; VILLAGRASA, B.; SANTABÁRBARA, J. PTSD in teachers: a mini meta-analysis during COVID-19. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 20, 1802, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph20031802>. Acesso em: 19 jan. 2026.

MONTE, L. L. *et al.* Programa Saúde na Escola: avanços, dificuldades e desafios na promoção da saúde nas escolas do Brasil. **Revista de APS**, v. 26, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/e262338864>. Acesso em: 11 maio 2025.

MORAES CRUZ, R.; RUPPEL DA ROCHA, R. E.; ANDREONI, S.; DUARTE PESCA, A. Retorno ao trabalho? Indicadores de saúde mental em professores durante a pandemia da

COVID-19. **Revista Polyphonia**, Goiânia, v. 31, n. 1, p. 325-344, 2020. DOI: 10.5216/rp.v.31, n. 1.66964. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/sv/article/view/66964>. Acesso em: 10 fev. 2025.

MORAIS, L. R. G. A.; DE MELO, R. F.; FERRAZ, L. C.; CORDEIRO, I. A. Saúde pública: desafios e oportunidades para transformar o cuidado da saúde no século XXI. **Anais New Science Publishers, Editora Impacto**, [S. l.], v. 1, n. 1, 2024. DOI: 10.56238/I-CIM-016. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/ans/article/view/1247>. Acesso em: 12 mar. 2025.

MOREIRA, D. Z.; RODRIGUES, M. B. Saúde mental e trabalho docente / Mental health and teaching / La salud mental y la enseñanza. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 23, n. 3, p. 236-247, jul./set. 2018. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/epsic/v23n3/a04v23n3.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2025.

MOREIRA, R. S. O trabalho na Educação Infantil: fatores associados aos sintomas de depressão maior em professores e auxiliares de classe. 2019. 78 p. **Dissertação – Programa de Pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho, Faculdade de Medicina, Universidade Federal da Bahia**, Salvador, 2019. Disponível em: https://sat.ufba.br/sites/sat.ufba.br/files/dissertacao_regina_de_souza_moreira.pdf. Acesso em: 24 abr. 2024.

MORENO-JIMENEZ, B. *et al.* A avaliação do Burnout em professores. Comparação de instrumentos: CBP-R e MBI-ED. **Psicologia em Estudo**, v. 7, n. 1, p. 11-19, jan. 2002.

MOTA, L. O. E. Políticas públicas nas áreas da saúde e da qualidade de vida dos profissionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal: um levantamento das possíveis redes de apoio ao bem-estar e à saúde mental dos professores. **Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal**, Brasília, v. 9, n. 4, p. 1-18, nov. 2022. Disponível em: <https://periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/view/1471>. Acesso em: 5 maio 2025.

NASCIMENTO, K. B.; SEIXAS, C. E. O adoecimento do professor da Educação Básica no Brasil: apontamentos da última década de pesquisas. **Revista Educação Pública**, v. 20, n. 36, set. 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/36/o-adoecimento-do-professor-da-educacao-basica-no-brasil-apontamentos-da-ultima-decada-de-pesquisas>. Acesso em: 1 abr. 2024.

NETO, R. C. A. Professores Também Sentem Solidão: Estudo das Características Pessoais e Profissionais de Docentes Associadas à Solidão. **Psico**, [S. l.], v. 46, n. 3, p. 321-330, 2015. DOI: 10.15448/1980-8623.2015.3.18265. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/revistapsico/article/view/18265>. Acesso em: 1 dez. 2025.

NEVES, M. Y. R.; SILVA, E. S. A dor e a delícia de ser (estar) professora: trabalho docente e saúde mental. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, v. 6, n. 1, p. 63-75, 2006. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/epp/v6n1/v6n1a06.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2026.

OLIVEIRA, E. C. de; SANTOS, M. A. A. Políticas públicas em saúde mental e trabalho docente: uma revisão crítica da literatura. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 4, n. 10, p. e5997, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N10-033. Disponível em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/5997>. Acesso em: 13 fev. 2025.

OLIVEIRA, E. C. de; SANTOS, V. M. dos. Adoecimento mental em professores brasileiros. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SIMEDUC, 10., 2021. Disponível em: <https://eventosgrupotiradentes.emnuvens.com.br/simeduc/article/view/14868>. Acesso em: 11 mar. 2025.

OPAS. **Depressão**. 2018. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/depressao>. Acesso em: 24 abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Depressive disorder (depression)**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>. Acesso em: 22 dez. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Depressão**. Genebra: OMS, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>. Acesso em: 13 maio 2025.

PAIVA, P. C.; FERREIRA, T. S.; LOPES JÚNIOR, J. E. G.; MACIEL, J. M.; COSTA, N.; CALLOU FILHO, C. R.; SILVA JÚNIOR, A. S.; JORGE, M. S. B. Sofrimento psíquico de docentes universitários no Brasil: revisão de escopo / Psychic Suffering of University Professors in Brazil: Scoping Review. **IOSR Journal of Humanities and Social Science**, v. 30, n. 7, série 5, p. 32-50, jul. 2025.

PENEDO. **Secretaria Municipal de Saúde**. Centro de Atenção Psicossocial Dr. Oceano Carleal. Cartilha de orientação em saúde mental – Em direção ao território. Penedo/AL: Prefeitura Municipal de Penedo, 2018. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431312/3/cartilha%20SM%20CAPS%20Penedo%202018%20%20%281%29.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2025.

PEREIRA, M. M.; MARÇULO, A. O. R.; CHINELATO, R. S. C.; FERREIRA, M. C. Anxiety and coping strategies during the Covid-19 pandemic: the mediating role of positive attitudes at work. **Estudos de Psicologia**, Natal, v. 25, n. 2, p. 167-176, 2020.

PINHO, P. S. *et al.* **Trabalho remoto docente e saúde: repercussões das novas exigências em razão da pandemia da Covid-19**. Trabalho, Educação e Saúde, v. 19, 2021, e00325157. DOI: 10.1590/1981-7746-sol00325. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00325>. Acesso em: 13 maio 2024.

PORTO ALEGRE (RS). **Secretaria Municipal de Saúde**. Saúde do Trabalhador. 2025. Disponível em: <https://prefeitura.poa.br/sms/vigilancia-em-saude/o-que-e-o-cerest>. Acesso em: 11 maio 2025.

POSSA, J. D. B.; KRAUSE, M. Saúde mental dos professores na contemporaneidade: impactos educacionais. **Revista Saberes e Sabores Educacionais**, v. 10, p. 153-168, 2023.

PUPO, L. R. *et al.* Saúde mental na Atenção Básica: identificação e organização do cuidado no estado de São Paulo. **Saúde em Debate**, v. 44, spe 3, p. 107-127, 2020. DOI:

10.1590/0103-11042020E311. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042020E311>. Acesso em: 18 mar. 2025.

QUADROS NIZA, C.; FERREIRA, R.; MARQUES, M.; GONÇALVES, A. Saúde mental dos professores do ensino superior no trabalho: revisão integrativa da literatura. **Servir**, [S. l.], v. 2, n. 12, p. e39102, 2025. DOI: 10.48492/servir0212.39102. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/servir/article/view/39102>. Acesso em: 8 nov. 2025.

RAMOS, D. K.; ANASTÁCIO, B. S.; SILVA, G. A. da; PIRES, L. U. R. Professores na pandemia: fatores e condições associados à Síndrome de Burnout. **Pro-posições**, v. 34, 2023. DOI: 10.1590/1980-6248-2021-0100. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2021-0100>. Acesso em: 18 jan. 2026.

RAMOS, L. S.; MONTEIRO, R. C.; SPINOLA, M. L.; PRETTI, p. de C.; MARVILA, R. p. M.; PANCIERI, C.; RAMOS, D. R.; OLIVEIRA, R. F. p.; SANTO, A. R. F. do E.; MANTIOLHE, T. da S. O ambiente escolar incapaz de assegurar a saúde mental do professor: uma revisão literária. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 49, p. e3416, 29 maio 2020. DOI: 10.25248/reas.e3416.2020. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e3416.2020>. Acesso em: 18 jan. 2026.

RIBAS, N.; MACHADO BARBOSA, A.; BUENO, L. R.; LARA, S. Adoecimento de professores do ensino básico e fatores associados: uma revisão de literatura. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 3, e16116, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.3-077. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/16116>. Acesso em: 18 jan. 2026.

RIBEIRO, Victor Barbosa *et al.* Alteração do estado emocional de professores da educação básica brasileira. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 40, n. 121, p. 28-37, abr. 2023. DOI: 10.51207/2179-4057.20230003. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862023000100004&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 1 fev. 2025.

RIVERO, D. E. D.; RODELO, L. A. A. Política pública de cobertura educativa e saúde mental dos docentes: estratégias para sua otimização. **Revista Boletín Redipe**, [S. l.], v. 7, n. 9, p. 148-160, 12 set. 2018. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6557297>. Acesso em: 8 maio 2025.

ROCHA, S.; STANISCUASKI, F.; NUDELMAN, M. F. *et al.* The impact of parenthood on mental health within the academic community: highlighting vulnerabilities and identifying high-risk groups. **Humanities and Social Sciences Communications**, v. 12, p. 893, 2025. DOI: 10.1057/s41599-025-05178-z. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/s41599-025-05178-z>. Acesso em: 18 jan. 2026.

RODRIGUES, L. T. M. *et al.* Estrés y depresión en docentes de una institución pública de enseñanza. **Enfermería Global**, v. 19, n. 1, p. 209-42, dic. 2019. DOI: 10.6018/eglobal.19.1.383201. Disponível em: <https://revistas.um.es/eglobal/article/view/383201>. Acesso em: 18 jan. 2026.

RONDINI, C. A.; DUARTE, C. dos S.; PEDRO, K. M. Pandemia do covid-19 e o ensino remoto emergencial: mudanças na práxis docente. **Interfaces Científicas: Educação**, v. 8, n.

1, p. 41-57, 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9085>. Acesso em: 18 jan. 2026.

SANTANA, M. S.; MENDES, C. p. Saúde mental dos professores do ensino superior: impactos da COVID-19. **Perquirere**, Patos de Minas, v. 22, n. 1, p. 536-550, 2025. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/perquirere/article/view/5388/3303>. Acesso em: 24 nov. 2025.

SANTOS, I. S. *et al.* Sensibilidade e especificidade do Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) entre adultos da população geral. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 8, p. 1533-1543, ago. 2013.

SANTOS, L. R.; SANTOS, Y. do R.; DOS ANJOS, D. S.; CICOTTI, R. Impactos da pandemia de COVID-19 na qualidade de vida de professores de escolas públicas estaduais de um município Sergipano, Brasil. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 7126-7141, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n1-581. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/67594>. Acesso em: 1 fev. 2025.

SANTOS, M. N.; MARQUES, A. C.; NUNES, I. J. Condições de saúde e trabalho de professores no ensino básico no Brasil: uma revisão. **EFDeportes.com Revista Digital**, Buenos Aires, v. 15, n. 166, mar. 2012. Disponível em: <https://efdeportes.com/efd166/condicoes-de-saude-e-trabalho-de-professores.htm>. Acesso em: 29 maio 2024.

SCHEIER, M.F.; CARVER, C. S. Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. *Health Psychology*, v. 4, n. 3, p. 219–247, 1985. DOI: 10.1037/0278-6133.4.3.219.

SEGAT, E.; DIEFENTHAELER, H. S. Uso de medicamentos antidepressivos por professores de escolas de diferentes redes de ensino em um município do norte do Rio Grande do Sul. **Perspectiva**, v. 37, n. 137, p. 45-54, mar. 2013. Disponível em: http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/137_324.pdf. Acesso em: 8 set. 2024.

SILVA, A. S. F. *et al.* Ansiedade e depressão em professores da rede básica de ensino da educação brasileira: revisão sistemática. **Pedagogia em Ação**, v. 18, n. 1, 1 sem. 2022. Disponível em: <https://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/28836/19816>. Acesso em: 27 jan. 2025.

SILVA, E. F.; VIEIRA, A. M. D. p. Adoecimento docente nas escolas públicas do estado do Paraná. **Humanidades & Inovação**, v. 8, n. 59, p. 181-192, 2022. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2273>. Acesso em: 18 fev. 2025.

SILVA, L. F.; OLIVEIRA, A. M. B.; HONORATO, A. E. O.; OLIVEIRA, A. J. Relação entre Transtornos Mentais Comuns e Características Docentes da Educação Básica. **Revista Psicologia: Organizações e Trabalho**, v. 23, n. 2, p. 2437-2445, 2023. DOI: 10.5935/rpot/2023.2.24400. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/rpot/2023.2.24400>. Acesso em: 18 jan. 2026.

SOARES, M. M.; OLIVEIRA, T. G. D. D.; BATISTA, E. C. O uso de antidepressivos por professores: uma revisão bibliográfica. **REVASE, Petrolina-PE**, v. 7, n. 12, p. 61-78, abr. 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/331049651_o_uso_de_antidepressivos_por_professores_uma_revisao_bibliografica_the_use_of_antidepressants_by_teachers_a_literature_review. Acesso em: 18 jan. 2026.

SOARES, N. M.; ROSSETTO, E. Saúde mental e docência no ensino superior: uma pesquisa bibliográfica / Mental health and teaching in higher education: a bibliographical research. **Humanidades & Inovação**, Palmas, v. 11, n. 3, p. 206-222, 2024. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/8138/4649>. Acesso em: 10 nov. 2025.

SONG, K. Well-Being of Teachers: The Role of Efficacy of Teachers and Academic Optimism. **Frontiers in Psychology**, v. 12, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.831972>. Acesso em: 18 jan. 2026.

SORIA-SAUCEDO, R.; LOPEZ-RIDAURAB, R.; LAJOUS, M.; WIRTZ, V. J. The prevalence and correlates of severe depression in a cohort of Mexican Teachers. **Journal of Affective Disorders**, v. 234, p. 109-116, 2018. DOI: 10.1016/j.jad.2018.02.036. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.036>. Acesso em: 18 jan. 2026.

SOUSA, C. C. de; ARAÚJO, T. M. de. Efeitos combinados de gênero, raça e estressores ocupacionais na saúde mental. **Revista Brasileira De Saúde Ocupacional**, v. 49, edepi12, 2024. DOI: 10.1590/2317-6369/15222pt2024v49edepi12. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6369/15222pt2024v49edepi12>. Acesso em: 18 jan. 2026.

SOUZA E SILVA, N. S.; LEÃO, L. L.; BARBOSA, R. E. C.; SILVEIRA, M. F.; SILVA, R. R. V.; HAIKAL, D. S. Diagnóstico de ansiedade e depressão entre professores durante a pandemia da COVID-19. **Psicologia e Saúde em debate**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 908-923, 2024. DOI: 10.22289/2446-922X.V10N1A55. Disponível em: <https://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/1134>. Acesso em: 9 fev. 2025.

SOUZA, E. M. R. de; COUTINHO, D. J. G. Adoecimento das professoras das primeiras letras em olinda: sintomas, queixas e diagnósticos. **Educação em Revista**, v. 34, e188055, 2018. DOI: 10.1590/0102-4698188055. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-4698188055>. Acesso em: 18 jan. 2026.

SOUZA, V. G. R.; TABORDA, J. C.; FREITAS, C. J. Desgaste da saúde mental do docente da educação básica no interior do Mato Grosso do Sul. **Humanidades & Inovação**, Palmas, v. 8, n. 41, p. 79-88, 2021. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/5101>. Acesso em: 26 abr. 2024.

SPÍNDOLA, T. Mulher, mãe e trabalhadora de enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 34, n. 4, p. 354-61, dez. 2000. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-508490>. Acesso em: 28 dez. 2023.

SPINDOLA, T.; SANTOS, R. S. Mulher e trabalho: a história de vida de mães trabalhadoras de enfermagem. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S. l.], v. 11, n. 5, p. 593-600, 2003. DOI: 10.1590/S0104-11692003000500005. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rlae/article/view/1806>. Acesso em: 28 dez. 2023.

SUE, D. W.; CAPODILUPO, C. M.; TORINO, G. C.; BUCCERI, J. M.; HOLDER, A. M. B.; NADAL, K. L.; ESQUILIN, M. R. Racial microaggressions in everyday life: implications for clinical practice. **American Psychologist**, v. 62, n. 4, p. 271-286, 2007. DOI: 10.1037/0003-066X.62.4.271. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271>. Acesso em: 18 jan. 2026. Taati Jeliseh, M.; KOLEINI, N.; ZOHRABI, M. et al. Examining the contributions of hope and optimism to teacher wellbeing and burnout through a structural equation modeling analysis. *Discover Psychology*, v. 5, 105, 2025. DOI: 10.1007/s44202-025-00454-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s44202-025-00454-0>. Acesso em: 18 jan. 2026.

TEIXEIRA, Afonso Celso. Adoecimento mental: professores apagados. **Sinpro Rio em Foco**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 87-90, 2025. Disponível em: <https://sinprorioemfoco.org/revista/article/view/12>. Acesso em: 27 fev. 2025.

TELYANI, A. E.; FARMANESH, p.; ZARGAR, p. The Impact of COVID-19 Instigated Changes on Loneliness of Teachers and Motivation–Engagement of Students: A Psychological Analysis of Education Sector. *Frontiers in Psychology*, v. 12, 2021. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.765180. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2021.765180/full>. Acesso em: 18 jan. 2026.

TOLEDO, L. C.; CAMPOS, C. R. Síndrome de burnout, satisfação de vida, autoestima e otimismo em docentes universitários durante o ensino remoto. **Educação em Revista**, v. 39, e39136, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-469839136>. Acesso em: 19 jan. 2026.

TREVISAN, R. K. R.; MORAES, C. R.; DALAGASPERINA, p.; ORNELLAS, A. D.; STEIL, A. V. Revisão sistemática internacional sobre agravos à saúde mental de professores. *Avances en Psicología Latinoamericana*, v. 40, n. 1, p. 1-15, 2022. DOI: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.7532. Disponível em: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/article/view/7532>. Acesso em: 18 jan. 2026.

VALENTE, G.; MORAES, E.; SANCHEZ, M.; DE SOUZA, D.; PACHECO, M. O ensino remoto frente às exigências do contexto de pandemia: Reflexões sobre a prática docente. **Research, Society and Development**, v. 9, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.8153. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.8153>. Acesso em: 18 jan. 2026.

VEDOVATO, G. T.; MONTEIRO, I. M. Perfil sociodemográfico e condições de saúde e trabalho dos professores de nove escolas estaduais paulistas. **Frontiers in Psychology**, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 7-290, 2008.

VIEIRA, M. A. *et al.* Saúde mental na escola. In: ESTANISLAU, G. M.; BRESSAN, R. A. (org.). **Saúde Mental na Escola: o que os educadores devem saber**. São Paulo: Artmed, 2014. p. 13-23. Disponível em:

<https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/5954>. Acesso em: 31 jan. 2019.

VIEIRA, M. R. M. *et al.* Inter-relações entre insatisfação com o trabalho docente e sintomas depressivos: modelagem com equações estruturais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 7, p. 2075-2086, jul. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nHRV9DDssF8nCGkxtG9xv3R/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 24 abr. 2024.

WERNECK, G. L.; CARVALHO, M. S. A pandemia de COVID-19 no Brasil: crônica de uma crise sanitária anunciada. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 5, e00068820, 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2020000500101&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 26 out. 2020.

WILLIAMS, D. R.; LAWRENCE, J. A.; DAVIS, B. A. Racism and Health: Evidence and Needed Research. **Annual Review of Public Health**, v. 40, p. 105-125, 2019. DOI: 10.1146/annurev-publhealth-040218-043750. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-043750>. Acesso em: 18 jan. 2026.

ZHONG, S.; HU, J.; XU, H. The impact of family support on depression among primary and secondary school teachers in China: the serial mediating roles of subjective time pressure and work-family conflict. **BMC Psychology**, v. 13, p. 1280, 2025. DOI: 10.1186/s40359-025-03543-w. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03543-w>. Acesso em: 18 jan. 2026.

ZIMMERMAN, M. M. D. Using the 9-Item Patient Health Questionnaire to Screen for and Monitor Depression. **Clinical Review & Education**, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31626276/>. Acesso em: 18 jan. 2026.

ZOTTELE, K. I.; ROCHA, M. O. Trabalho docente, saúde mental e adoecimento na rede pública básica de ensino. **Cadernos de Psicologias**, n. 6, 2024.

**ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO
PESQUISADO (FORMATO ONLINE)**

REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Informações aos participantes

1) Dados de identificação do projeto

Título do Projeto: Avaliação da Saúde Mental Em Profissionais E Estudantes

Do Ensino Superior E Profissionais do Ensino Básico Na Pandemia De COVID-19

Pesquisador Responsável: Leticia Oliveira, Mirtes Pereira e Marta Nudelman

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Departamento de Fisiologia e Farmacologia – UFF (Universidade Federal Fluminense)

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 2629-2548 Contato do pesquisador (e-mail): martanudelman@id.uff.br

Nome do Participante: _____

2) Convite

Você está sendo convidado(a) a participar da terceira etapa da pesquisa AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAIS DO ENSINO BÁSICO NA PANDEMIA DE COVID-19. Antes de decidir se participará, é importante que você entenda o motivo do estudo que está sendo feito e o que ele envolverá. Reserve um tempo para ler cuidadosamente as informações a seguir. Não tenha pressa de decidir se deseja ou não participar desta pesquisa.

3) O que é o projeto?

O projeto foi desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense em colaboração com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal de Ouro Preto, sob a coordenação das professoras Leticia de Oliveira e Mirtes Pereira Garcia. O objetivo é entender como você, profissional ou estudante, está lidando no momento com os desafios emocionais que surgem a partir da pandemia e as suas consequências ao longo do tempo, a partir do preenchimento de questionários online.

4) Qual é o objetivo do estudo?

Essa pesquisa foi elaborada com o intuito de entender melhor as possíveis consequências dessa pandemia relacionadas à saúde mental dos profissionais e estudantes e não tem a intenção de causar nenhum prejuízo.

5) Por que eu fui escolhido(a)?

O critério de inclusão para participação na pesquisa engloba ser maior de 18 anos, docente do ensino superior ou básico das redes públicas e/ou privadas, e/ou ser discente do ensino superior de rede pública e/ou privada ou ser técnico administrativo de faculdade ou Universidade. Lembrando que a participação é voluntária, conforme desejo e autorização dos interessados.

6) Eu tenho que participar?

Você é quem decide se gostaria de participar ou não deste estudo. Se decidir participar do projeto AVALIAÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAIS DO ENSINO BÁSICO NA PANDEMIA DE COVID-19 você deverá assinar este Registro e poderá imprimir uma via assinada pelo pesquisador, a qual você deverá guardar. Mesmo se você decidir participar, você ainda tem a liberdade de se retirar das atividades a qualquer momento, sem qualquer justificativa. Isso não afetará em nada sua participação em demais atividades e não causará nenhum prejuízo.

7) O que acontecerá comigo se eu participar? O que eu tenho que fazer?

- Confirmada sua participação, a próxima página dará acesso ao questionário online, no qual será pedido o preenchimento de todos os itens.

- Após o preenchimento deste questionário, você terá acesso a um breve texto com orientações para manter a saúde mental nesse momento.

- Além disso, por tratar-se de uma pesquisa que pretende investigar, ao longo do tempo, o impacto que a pandemia de COVID-19 pode estar causando e venha a causar na saúde mental das pessoas, ao final desta primeira etapa, você irá informar se deseja participar das próximas etapas. Se você concordar, será convidado por mais duas vezes, com a única finalidade de dar continuidade a esse estudo. Sua participação nas próximas etapas será opcional.

8) O que é exigido de mim nesse estudo?

O desejo em participar e o preenchimento de todos os itens dos questionários para que seja possível analisar os dados de maneira precisa, caso concorde em participar do experimento.

9) Eu terei alguma despesa ao participar da pesquisa?

Não haverá nenhum tipo de despesa em participar dessa pesquisa.

10) Quais são os eventuais riscos ao participar do estudo?

De acordo com as Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, todas as pesquisas envolvem riscos, ainda que mínimos. Além disso, é importante ressaltar que os questionários aqui apresentados investigarão eventos traumáticos vivenciados pelo indivíduo e poderão gerar um possível desconforto ou mal-estar durante o preenchimento. Isso poderá levar à lembrança de assuntos delicados e/ou eventos que causaram e/ou ainda causam sofrimento psíquico, além de sintomas físicos característicos de ansiedade. Outros sintomas como emoções negativas e irritabilidade também podem ser percebidos.

11) Quais são os possíveis benefícios de participar?

Essa investigação espera ampliar o entendimento a respeito da gravidade da vivência de eventos traumáticos em uma pandemia e pretende contribuir na elaboração de medidas concretas para proteção dos profissionais e estudantes durante uma pandemia. Como participante você estará contribuindo para o entendimento dos possíveis prejuízos de uma pandemia sobre a saúde mental e terá acesso a um breve texto com orientações para manter a saúde mental nesse momento.

12) O que acontece quando o estudo termina?

Os resultados desse estudo irão originar artigos, publicações em revistas, congressos e toda a produção e informativos serão disponibilizados no nosso site www.psicovida.org

13) E se algo der errado?

Caso sinta algum desconforto durante o preenchimento, você poderá solicitar ajuda através do nosso e-mail psicovida.uff@gmail.com ou através de nosso site (www.psicovida.org), onde você terá acesso ao contato de instituições que oferecem suporte psicológico online. Estaremos disponíveis através dos meios já mencionados caso você precise de apoio ou ajuda. Além disso, é importante enfatizar que a qualquer momento do preenchimento, você é livre para encerrar sua participação e minimizar qualquer tipo de desconforto.

Além dos possíveis riscos relacionados ao desconforto gerado por lembranças de assuntos que causaram e/ou ainda causam sofrimento psíquico, este estudo envolve questionários que serão armazenados em um banco de dados digital online, em que existe um risco mínimo de acesso aos dados por hackers.

Entretanto, o acesso será restrito aos pesquisadores, e assim que os formulários forem preenchidos serão retirados da “nuvem” e armazenados apenas em um computador físico dos pesquisadores responsáveis pela pesquisa, garantindo assim a privacidade e sigilo dos dados.

14) Minha participação neste estudo será mantida em sigilo?

Os dados obtidos com seu preenchimento serão usados apenas com objetivos científicos, não sendo possível a identificação individual. Tendo acesso apenas os pesquisadores responsáveis pela pesquisa, garantindo assim a privacidade e sigilo dos dados.

15) Contato para informações adicionais

Em caso de dúvidas, sugestões ou esclarecimentos, entre em contato conosco através dos e-mails psicovida.uff@gmail.com ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFF através do telefone +55 (21) 2629-9189 ou e-mail etica.ret@id.uff.br.

Caso prefira, entre em contato direto com nossa pesquisadora responsável: - Marta Nudelman

martanudelman@id.uff.br

Rua Hernani Mello 101, Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFF, Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, sala 203 bloco Y. São Domingos, Niterói - Rio de Janeiro/ CEP: 24210-130

Telefones: 2629-2548

Dados do CEP:

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

E-mail: etica.ret@id.uff.br Tel/fax: (21) 26299189

16) Remunerações financeiras

Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto pela sua participação nesta pesquisa.

Obrigado por ler estas informações. Se deseja participar deste estudo, assine este Registro de Consentimento Livre e Esclarecido e devolva-o ao(à) pesquisador(a). Você deve imprimir e guardar uma via deste documento para sua própria garantia.

1 – Confirmando que li e entendi as informações sobre o estudo acima e que tive a oportunidade de fazer perguntas.

2 – Entendo que minha participação é voluntária e que sou livre para retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar dar explicações, e sem sofrer prejuízo ou ter meus direitos afetados.

☐ Concordo com os termos acima.

☐ Não concordo com os termos acima.

6.3 Encaminhamentos para grupos de Atendimento Psicológico Online

1) Agir para Salvar Vidas

Através de uma plataforma, de acesso gratuito, conectamos profissionais da Saúde Mental para atender voluntariamente todos na linha de frente contra o COVID-19. Queremos apoiar você, profissional da Saúde! Gostaria de fazer parte? Inscreva-se nos formulários. <https://www.agirparasalvarvidas.com.br/>

2) Psicólogos contra a COVID-19

Atendimento psicológico online para profissionais de saúde

Laura Labanca: (21)98919-1994

Luiza Peña: (21)99859-1919

3) Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental (LaPICC-USP)

Como parte do Departamento de Psicologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (USP), oferece atendimento de apoio em grupo visando auxiliar nesse momento de crise que estamos vivendo.

O presente atendimento não substitui o seu tratamento psicológico em andamento, trata-se de intervenção de apoio para manejo da situação de crise.

Para se inscrever é necessário preencher esse formulário que se encontra no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN44mEm346ezJcowEsQkP_mBTswD578XkKtBmiVR21LcqZnA/viewform e aguardar o contato de um dos integrantes do laboratório.

Existem vagas para os 7 diferentes grupos descritos abaixo:

A-Terapia Focada na Compaixão (protocolo com teoria, exercícios e práticas meditativas para auxiliar na saúde mental em momentos de crise)

B-Manejo de ansiedade e estresse para profissionais de saúde (esse grupo é destinado para profissionais/equipe de saúde que estão atuando na linha de frente no combate à COVID-19)

C-Manejo de ansiedade geral e estresse (esse grupo se destina a desenvolver apoio para manejo de ansiedade e estresse em adultos em geral, além de manejo das dificuldades na rotina)

D-Manejo de ansiedade e estresse para professores (esse grupo se destina a manejo de ansiedade e estresse relacionados às atividades dos professores durante a pandemia, além de manejo das dificuldades na rotina)

E-Orientação para pais e filhos em tempos de isolamento social (esse grupo se destina a pais de crianças e adolescentes a fim de discutir estratégias de manejo para lidar com a fase de isolamento social, além de manejo das dificuldades na rotina)

F-Manejo de ansiedade e estresse para adolescentes (esse grupo se destina a manejo de ansiedade, estresse, frustração e tédio dos adolescentes durante a pandemia, além de manejo das dificuldades na rotina)

G-Manejo de ansiedade e estresse para estudantes universitários (esse grupo se destina a manejo de ansiedade, estresse, frustração e tédio dos estudantes universitários durante a pandemia, além de manejo das dificuldades na rotina) Todos os grupos são voltados para maiores de 18 anos, com exceção do grupo de adolescentes. Para este último grupo, a idade mínima é de 14 anos.

4) Somos Todos Um - Grupo de Suporte em Saúde Mental para profissionais de saúde durante a Pandemia de COVID-19

Grupo composto por profissionais de saúde mental (psiquiatras e psicólogos especializados em terapia cognitivo-comportamental), com formação acadêmica no nível de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) e experiência clínica no atendimento de adultos.

Oferece atendimento online voluntário aos profissionais da área de saúde que estejam atuando nas emergências e UTIs dos hospitais de Niterói/RJ durante a pandemia do COVID-19.

Como participar:

Os interessados deverão enviar e-mail para equipe.somostodosum@yahoo.com colocando o seu nome completo, telefones para contato e formação profissional, para que - no prazo máximo de 48h – possamos retornar o contato. É necessário: (a) Ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ou fisioterapeuta; (b) ter acima de 18 anos; (c) não estar sendo atendido por psicólogo e/ou psiquiatra no momento; d) ter o horário compatível com profissional do SOMOS TODOS UM; (e) dispor de celular ou computador a ser usado em local com privacidade para o atendimento por videoconferência. O aplicativo a ser utilizado será definido em consenso com nossa equipe e o profissional que deseja o atendimento.

As vagas são limitadas e a duração do atendimento prestado será avaliada, caso a caso, respeitando o critério de que cada profissional atendido possa usufruir dos nossos serviços por até 2 (dois) meses de atendimentos semanais, para que possamos contemplar, com a nossa ajuda, o maior número de pessoas possível.

5) Atendimento psicológico ao profissional de saúde

O instituto Anatta oferece consulta gratuita, por modalidade on-line, podendo ser Skype ou WhatsApp, para o acolhimento aos profissionais de saúde envolvidos no combate à COVID-19. As consultas poderão ser usadas para falar sobre qualquer desdobramento da vida profissional que será vivenciada durante o período de pandemia.

Entre em contato para maiores informações via direct @institutoanattaou e-mail: institutoanatta@gmail.com.

ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Por favor, responda às questões abaixo:

1) Por favor, insira seu email:

2) Você se encaixa em qual categoria:

- ☐ Docente do ensino superior ☐ Técnico Administrativo de ensino Superior e/ou pesquisa ☐ Discente de Graduação do Ensino Superior ☐ Discente de Pós-graduação ☐ Pesquisador de Pós-doutorado ☐ Docente do Ensino Básico ☐ Nenhuma das alternativas (encerrar questionário se marcar esta opção)

1.1(Condicional caso marque superior) Você é vinculado como professor em algum curso de pós-graduação stricto sensu?

- a. Não
- b. Sim, como docente permanente
- c. Sim, como docente colaborador
- d. Sim, como docente visitante
- e. Sim, como co-orientador

1.2 Você é bolsista de produtividade em pesquisa (PQ) ou de desenvolvimento tecnológico (DT) do CNPq??

- a. Não
- b. Sim, nível 2
- c. Sim, nível 1d
- d. Sim, nível 1c
- e. Sim, nível 1b
- f. Sim, nível 1a
- g. Sim, nível sênior

1.3 (Condicional para discente e docente do ensino superior) Qual a sua grande área de atuação:

- a. Ciências Exatas e da Terra
- b. Ciências Biológicas

- c. Engenharias
- d. Ciências da Saúde
- e. Ciências Agrárias
- f. Linguística, Letras e Artes
- g. Ciências Sociais Aplicadas
- h. Ciências Humanas

2.Você trabalha em algum hospital ou unidade de saúde?

- a. sim
- b. não

3.Você trabalhou na linha de frente na pandemia:

- a. Sim
- b. Não

4. Você é menor de idade:

- a. Sim (encerra o questionário se marcar esta opção)
- b. Não

5.Quantos anos você tem? (apenas números):

7. Você se identifica com o gênero:

- ☐ Feminino;
- ☐ Masculino;
- ☐ Não-binário;
- ☐ Prefiro não declarar
- ☐ Outra opção

7.Você é uma pessoa trans:

- a. Sim
- b. Não
- c. Prefiro não declarar

8. Raça:(obrigatório)

- ☐ Branca
- ☐ Parda
- ☐ Preta
- ☐ Amarela
- ☐ Indígena
- ☐ Não quero declarar

9. Em qual estado do Brasil você trabalha ou estuda?

- ☐ AC
- ☐ AL
- ☐ AM
- ☐ AP
- ☐ BA
- ☐ CE
- ☐ DF
- ☐ ES
- ☐ GO
- ☐ MA
- ☐ MG
- ☐ MS
- ☐ MT
- ☐ PA
- ☐ PB
- ☐ PE
- ☐ PI
- ☐ PR
- ☐ RJ
- ☐ RN
- ☐ RO
- ☐ RR
- ☐ RS
- ☐ SC
- ☐ SE
- ☐ SP

☐ TO

10. Qual(ais) o(s) nome(s) ou a sigla(s) da(s) sua(s) instituição(ões)?

11. Qual o tipo de instituição de ensino que você trabalha ou estuda?

☐ Público

☐ Particular

☐ Comunitária

(permitir mais de uma opção)

12. Você já retornou às atividades presenciais?

a. Sim

b. Não

c. Parcialmente

d. Não interrompi as atividades presenciais em nenhum momento da pandemia

e. (condicional para sim e parcialmente)

Qual o nível de estresse que você sentiu relacionado a este retorno:

(nenhum) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (extremo)

(condicional para quem não interrompeu)

Qual o nível de estresse que você sentiu por não ter parado as atividades presenciais:

(nenhum) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (extremo)

13. Você teve alguma dessas patologias diagnosticadas por um psicólogo ou psiquiatra, antes do início da pandemia?

☐ Depressão

☐ Ansiedade generalizada

☐ Pânico

☐ Transtorno Bipolar

☐ Transtorno obsessivo-compulsivo

☐ Fobia

☐ Transtorno do Estresse Pós-traumático

☐ Burnout

☐ Outros transtornos (qual? _____)

☐ Não

13.1 (Condicional Caso marque sim) Durante a pandemia, você notou alguma alteração na sua saúde mental?

- a. sim, para melhor
- b. sim, para pior
- c. não

13. 2 (Condicional caso marque piora) Quanto foi essa piora?

(Pouco) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Totalmente)

13.3 (Condicional caso marque melhora) Quanto foi essa melhora?

(Pouco) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Totalmente)

14.Você tem filhos (as):

- a. Não
- b. Sim, um filho (a)
- c. Sim, dois filhos (as)
- d. Sim, três filhos (as)
- e. Sim, quatro filhos (as)
- f. Sim, mais que quatro filhos (as)

(Condicional a resposta sim na questão anterior)

14.1 Qual a idade do seu filho (a), se tiver mais de um, indique a idade do filho (a) mais novo:

obs Dropdown com as opções de idade, para seleção.

14. 2 Em relação aos cuidados e responsabilidade PRINCIPAL pela criação de filhos (as) você considera que:

- a. É a única pessoa responsável pelos cuidados e responsabilidades
- b. É a principal pessoa responsável pelos cuidados e responsabilidades
- c. Divide igualmente os cuidados e responsabilidades com outra pessoa
- d. Outra pessoa é a principal responsável pelos cuidados e responsabilidades
- e. Outra opção descreve melhor a divisão de cuidados e responsabilidades

13. 3 Em relação a rede de apoio para os cuidados com seus filhos (as):

- a. Possui rede de apoio de familiares e amigos
- b. Possui uma pessoa contratada para ajudar nos cuidados
- c. Possui, em horário integral, apoio de creches ou escolas
- d. Possui, em horário parcial, apoio de creches ou escolas
- e. Não possui rede de apoio
- f. Outro

(pode assinalar mais de uma opção)

14. 4 Você possui filho (a) com deficiência ou com doenças crônicas que precisa de cuidado permanente:

- a. Sim
- b. Não

15. (esta não é condicional) Você cuida de idosos ou pessoas (excluindo filhos) que precisam de cuidado permanente:

- a. Sim
- b. Não

16. Você faz parte do grupo de risco e/ou mora com alguém que pertença ao grupo de risco para COVID-19 (por idade ou comorbidades como hipertensão, obesidade, asma etc.)?

- ☐ Sim, eu faço parte do grupo de risco
- ☐ Sim, moro com alguém (familiar, amigo ou conhecido) que faz parte do grupo de risco
- ☐ Não

(abrir para mais de uma resposta)

17. Quanto à vacinação:

- a. Não estou vacinado
- b. Vacinado com a primeira dose
- c. Vacinado com a segunda dose (ou dose única)
- d. Vacinado com a terceira dose (reforço)

ANEXO C - QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DO PACIENTE

Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) Scale

Durante as últimas 2 semanas com que frequência você foi incomodado/a por qualquer um dos problemas a seguir?	Nenhuma das vezes	Vários dias	Mais da metade dos dias	Quase todos os dias
1. Pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas.	0	1	2	3
2. Se sentir “para baixo”, deprimido/ a ou sem perspectiva.	0	1	2	3
3. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormi mais do que costuma.	0	1	2	3
4. Se sentir cansado/a ou com pouca energia.	0	1	2	3
5. Falta de apetite ou comendo demais.	0	1	2	3
6. Se sentir mal consigo mesmo/a- ou acha que você é um fracasso ou que decepcionou sua família ou você mesmo/a.	0	1	2	3
7. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver televisão.	0	1	2	3
8. Lentidão para se movimentar ou falar, a ponto das outras pessoas perceberem? Ou o oposto- estar tão agitado/a ou irrequieto/a que você fica andando de um lado para o outro muito mais do que de costume.	0	1	2	3
9. Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto/a.	0	1	2	3

If you checked off any problems how difficult have these problems made it for you to do your work, take care of things at home, or get along with other people?

Nenhuma dificuldade	Alguma dificuldade	Muita dificuldade	Extrema dificuldade
0	1	2	3

Escala de Gravidade de Sintomas de TEPT (Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5-PCL-5)

A seguir é apresentada uma lista de dificuldades que as pessoas podem enfrentar após vivenciar uma experiência muito traumatizante. Mantendo em mente o pior evento traumático relacionado à COVID que você escolheu, marque o quanto as dificuldades abaixo o incomodaram no último mês:

No último mês, quanto você foi incomodado por:	De modo nenhum	Um pouco	Moderadamente	Muito	Extremamente
1. Lembranças indesejáveis, perturbadoras e repetitivas da experiência estressante?	0	1	2	3	4
2. Sonhos perturbadores e repetitivos com a experiência estressante?	0	1	2	3	4
3. De repente, sentindo ou agindo como se a experiência estressante estivesse, de fato, acontecendo de novo (como se você estivesse revivendo-a, de verdade, lá no passado)?	0	1	2	3	4
4. Sentir-se muito chateado quando algo lembra você da experiência estressante?	0	1	2	3	4
5. Ter reações físicas intensas quando algo lembra você da experiência estressante (por exemplo, coração apertado, dificuldades para respirar, suor excessivo)?	0	1	2	3	4
6. Evitar lembranças, pensamentos, ou sentimentos relacionados à experiência estressante?	0	1	2	3	4
7. Evitar lembranças externas da experiência estressante (por exemplo, pessoas, lugares, conversas, atividades, objetos ou situações)?	0	1	2	3	4
8. Não conseguir se lembrar de partes importantes da experiência estressante?	0	1	2	3	4
9. Ter crenças negativas intensas sobre você, outras pessoas ou o mundo (por exemplo, ter pensamentos tais como: “Eu sou ruim”, “existe algo seriamente errado comigo”, “ninguém é confiável”, “o mundo todo é perigoso”)?	0	1	2	3	4
10. Culpar a si mesmo ou aos outros pela experiência estressante ou pelo que aconteceu depois dela?	0	1	2	3	4

11. Ter sentimentos negativos intensos como medo, pavor, raiva, culpa ou vergonha?	0	1	2	3	4
12. Perder o interesse em atividades que você costumava apreciar?	0	1	2	3	4
13. Sentir-se distante ou isolado das outras pessoas?	0	1	2	3	4
14. Dificuldades para vivenciar sentimentos positivos (por exemplo, ser incapaz de sentir felicidade ou sentimentos amorosos por pessoas próximas a você)?	0	1	2	3	4
15. Comportamento irritado, explosões de raiva ou agir agressivamente?	0	1	2	3	4
16. Correr muitos riscos ou fazer coisas que podem lhe causar algum mal?	0	1	2	3	4
17. Ficar “super” alerta, vigilante ou de sobreaviso?	0	1	2	3	4
18. Sentir-se apreensivo ou assustado facilmente?	0	1	2	3	4
19. Ter dificuldades para se concentrar?	0	1	2	3	4
20. Problemas para adormecer ou continuar dormindo?	0	1	2	3	4

Teste de Orientação da Vida (*Life Orientation Test*)

Marque com um X as questões abaixo a respeito de você , indicando o seu grau de acordo, seguindo a seguinte escala:

Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
0	1	2	3	4

Seja o(a) mais sincero (a) possível e procure não deixar sua resposta a uma questão influenciar suas respostas às outras questões. Não há respostas certas ou erradas.

1. Nos momentos de incerteza, geralmente eu espero que aconteça o melhor.	0	1	2	3	4
2. É fácil para mim, relaxar.	0	1	2	3	4
3. Se alguma coisa ruim pode acontecer comigo, vai acontecer.	0	1	2	3	4
4. Eu sou sempre otimista com relação ao meu futuro.	0	1	2	3	4
5. Eu gosto muito da companhia de meus amigos e amigas.	0	1	2	3	4
6. É importante para mim, manter-me em atividade.	0	1	2	3	4
7. Quase nunca eu espero que as coisas funcionem como eu desejaria.	0	1	2	3	4
8. Eu não me zango facilmente.	0	1	2	3	4
9. Raramente eu espero que coisas boas aconteçam comigo.	0	1	2	3	4
10. De maneira geral, eu espero que me aconteçam mais coisas boas do que coisas ruins.	0	1	2	3	4

Escala de Solidão (*Three-Item Loneliness Scale*; Hughes *et al.*, 2004)

Marque com que frequência, nos últimos seis meses, você se sente em cada uma das situações abaixo:

	Raramente	Algumas	Sempre
Com que frequência você sente que te falta companhia?			
Com que frequência você se sente deixado(a) de lado?			
Com que frequência você sente isolado(a) das outras pessoas?			